
👑 ARTRITIS REUMATOIDEA (AR): LA REINA DE LAS ARTRITIS CRÓNICAS 👑

La Artritis Reumatoidea (AR) es la artritis inflamatoria más frecuente. Es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica de etiología desconocida, caracterizada por la inflamación sinovial persistente que tiende a la **destrucción y deformidad articular**. Afecta entre el **0.5 y el 1% de la población adulta mundial** y es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres, con un pico de incidencia entre los 35 y 45 años.

✨ I. Criterios de Clasificación: Poniendo Puntos al Diagnóstico

Es fundamental recordar que los criterios existentes son de **clasificación** y no de diagnóstico, utilizados principalmente para homogeneizar grupos de pacientes en ensayos clínicos.

📖 Criterios ACR/EULAR 2010 (Los más recientes)

Estos criterios se utilizan para la clasificación de la AR definitiva, siendo necesaria una puntuación $\geq 6/10$ para la clasificación.

Dominio Evaluado	Criterios y Puntuación
A. Compromiso Articular	> 10 articulaciones (al menos 1 pequeña): 5 puntos
B. Serología (FR y/o Anti-CCP)	Positivos a títulos elevados (>3 el punto de corte): 3 puntos
C. Reactantes de Fase Aguda	PCR y VSG alteradas: 1 punto
D. Duración de los Síntomas	≥ 6 semanas: 1 punto

- **Nota Importante:** Estos nuevos criterios identifican más pacientes en fases precoces, pero han perdido algo de especificidad.

🖋️ II. Características Clínicas y Serológicas Clave

🎯 Patrón Típico de Afectación Articular

La AR se manifiesta típicamente como **poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones**.

- **Compromiso Articular:** Es una poliartritis (inflamación de 5 o más articulaciones).
- **Simetría:** El patrón de afección articular suele ser **simétrico** (afectación bilateral).
- **Sinovitis:** La lesión característica es la **sinovitis crónica**, la inflamación de la membrana sinovial.
- **Reactantes de Fase Aguda (RFA):** Los pacientes presentan **elevación de la VSG y la PCR**, que son muy útiles para el seguimiento y la monitorización de la actividad.

Clínica y Naturaleza del Dolor

El dolor en la AR es de naturaleza **inflamatoria**.

- **Dolor Inflamatorio:** **Empeora con el reposo** y típicamente es **dolor nocturno**.
- **Rigidez Matutina (RM):** Es un síntoma muy característico. Se refiere a la dificultad del movimiento al levantarse o después de un largo reposo.
 - Suele durar **más de 1 hora** cuando la enfermedad está activa.
 - Afecta varias articulaciones a ambos lados del cuerpo y **mejora con el movimiento**.
- **Otros Síntomas Comunes:** Astenia, fatiga (presente en el 40-80% de los pacientes), y en fases avanzadas, deformidad articular.

III. Articulaciones y Lesiones Típicas de Manos

Articulaciones Afectadas Generalmente

La AR tiene especial predilección por las **pequeñas articulaciones de manos y pies**, pero también puede afectar a grandes articulaciones.

- **Manos:** **Metacarpofalángicas (MCF)**, **Interfalángicas Proximales (IFP)**, y **carpos (muñecas)** son las que se afectan con mayor frecuencia al inicio.
- **Pies:** **Metatarsofalángicas (MTF)**.
- **Otras Frecuentes:** Hombros, codos, rodillas, tobillos.

Articulaciones que **NUNCA Afecta la AR Típica**

- **Interfalángicas Distales (IFD):** Estas articulaciones están específicamente excluidas de la evaluación de las pequeñas articulaciones en los criterios de clasificación ACR/EULAR 2010. Su compromiso es más característico de la **Artritis Psoriásica** o la **Artrosis**.
- **Eje Axial (Columna):** La AR **no afecta el esqueleto axial, a excepción de la región cervical**.

Lesiones Crónicas Típicas de los Dedos

- **Mano en ráfaga / Desviación Cubital:** Desviación de los dedos hacia el cúbito.
- **Dedos en Cuello de Cisne o en Ojal/Boutonniere:** Deformidades características.
- **Pulgar en Z.**
- **Carpo en Tecla de Piano:** Luxación dorsal de la estiloides cubital.
- **Nódulos Reumatoideos:** Bultos subcutáneos firmes e indoloros, presentes en el 20-30% de los pacientes, frecuentemente localizados en el olécranon o el tendón de Aquiles.

IV. Serología y Anticuerpos Claves

Los autoanticuerpos son marcadores importantes para el diagnóstico y el pronóstico.

Anticuerpos Específicos

Anticuerpo	Sensibilidad (S)	Especificidad (E)	Relevancia Clínica
Factor Reumatoideo (FR)	Similar a Anti-CCP (70-75% de los pacientes)	Baja (se observa en 5-10% de la población general y otras enfermedades)	Precursor de AR. Su presencia se asocia a enfermedad más grave y a manifestaciones extraarticulares.
Anti-Péptidos Cíclicos Citrulinados (Anti-CCP/ACPA)	Similar a FR	Muy alta (> 95%)	Más útil para diagnóstico temprano (poliartritis de inicio reciente). Su presencia indica alto riesgo de desarrollar AR y predice una enfermedad más destructiva.

Niveles de Factor Reumatoideo (FR) en la Clasificación ACR/EULAR 2010

La cuantificación del FR (y Anti-CCP) es importante para la puntuación pronóstica.

- **Negativo/Insignificante (0 puntos):** FR y Anti-CCP negativos.
- **Bajo/Débil (2 puntos):** FR y/o Anti-CCP positivos a títulos bajos (por encima del punto de corte, pero **no superan 3 veces** el límite superior de la normalidad).
- **Alto/Fuerte (3 puntos):** FR y/o Anti-CCP positivos a **títulos elevados** (superando **3 veces** el punto de corte de normalidad).

Niveles de Factor Reumatoide (FR) en Artritis Reumatoide (AR):

- **Insignificante / Negativo:** < 20 IU/mL (según laboratorio; valores normales)
- **Débil / Bajo positivo:** 20–40 IU/mL
- **Moderado:** 41–80 IU/mL
- **Fuerte / Alto positivo:** > 80 IU/mL

V. El Rol Crucial del Metotrexato (MTX)

El Metotrexato (MTX) es una **Droga Antirreumática Modificadora de la Enfermedad (DMAR)** esencial.

Terapia de Primera Línea

- **Elección:** La **monoterapia con Metotrexato** es la **primera elección terapéutica** para el tratamiento de la AR.
- **Objetivo:** Su efecto principal es **alterar el curso natural de la enfermedad**, suprimiendo la inflamación para evitar el daño radiológico y la discapacidad.
- **Dosis:** La dosis inicial varía entre 10 y 20 mg/semana. Se recomienda una **escalada rápida y mensual** (incrementos de 5 a 7.5 mg) hasta 30 mg por semana o la dosis máxima tolerada.
- **Suplementación:** La administración de MTX **debe estar asociada a ácido fólico**.
- **Falla Terapéutica:** Si la remisión no se logra en 12 semanas con MTX, se puede adicionar un segundo DMARD o, en casos de actividad de la AR, puede justificarse el paso a un agente biológico anti-TNF **sin necesidad** de haber recibido previamente otros DMARDs como sulfasalazina o hidroxicloroquina.

VI. Consecuencias Crónicas de la AR no Tratada

La AR es considerada una **enfermedad grave** que compromete la calidad de vida y la vida misma. Si no se administra un tratamiento adecuado:

- **Remisión:** La AR **raramente remite**.
- **Incapacidad Funcional:** Prácticamente todos los pacientes sufrirán dolor diariamente, y presentarán **incapacidad funcional severa a los 2 años** de evolución.
- **Daño Estructural:** El proceso destructivo comienza lenta y tempranamente desde el inicio, llevando a **severo daño radiológico, anquilosis y deformidad** si no se controla la inflamación.
- **Mortalidad Aumentada:** La mortalidad es **2 veces mayor** en comparación con la población general.

- El aumento de la mortalidad se debe, en parte, a la **aterosclerosis acelerada** y el **mayor riesgo cardiovascular** (responsable de hasta el 50% del incremento de mortalidad).
- **Manifestaciones Sistémicas Crónicas:** La enfermedad seropositiva (FR elevado) se asocia a mayor frecuencia de manifestaciones extraarticulares. Estas pueden incluir:
 - **Nódulos Reumatoideos** (subcutáneos o viscerales).
 - **Vasculitis Reumatoidea.**
 - **Queratoconjuntivitis seca.**
 - **Enfermedad pulmonar intersticial difusa** y derrame pleural.
 - **Subluxación atlantoaxoidea** (afección cervical).
 - **Amiloidosis.**

En resumen, el tratamiento oportuno (en la "ventana de oportunidad") con Metotrexato, dirigido a lograr la remisión, es la clave para evitar que el curso de la AR progrese de una sinovitis a una enfermedad destructiva, deformante y con riesgo vital. Es como correr contra el tiempo para apagar un incendio que, si se deja arder, fundirá los cimientos de la estructura. 🔥⌚

ARTRITIS REUMATOIDEA: **RADIOLOGÍA, PRONÓSTICO Y** **TRATAMIENTO DIRIGIDO AL BLANCO**



I. Evaluación Radiológica: Los Sitios "Alcahuete"

La **Radiología Simple** sigue siendo una herramienta útil para evaluar el daño articular. En la evaluación inicial, se recomienda realizar radiografías (Rx) de ciertas articulaciones y de la columna cervical.

¿Qué Buscamos y Qué Encontramos en la Rx?

1. En Fases Iniciales:

- **Engrosamiento de partes blandas.**
- **Osteopenia periarticular.**

2. En Fases Avanzadas (Lesiones Características):

- **Erosiones Subcondrales:** Son las lesiones más características de la AR. Aparecen a los pocos meses de evolución.
- **Pinzamiento o Reducción del Espacio Articular** (testimonio de la lesión del cartílago hialino).
- **Desaxación, subluxación y destrucción articular.**

Sitios Alcahuete (Rx Recomendadas)

Se recomienda realizar siempre estudios **pareados** o **bilaterales** en articulaciones simétricas.

- **Manos (Frente - F):** Esencial para buscar erosiones en **Metacarpofalángicas (MCF)**, **Interfalángicas Proximales (IFP)** y **Carpos**.
- **Pies (Frente y Perfil con Apoyo):** Es crítico buscar erosiones en las **Metatarsofalángicas (MTF)**, especialmente en la **5ª MTF**, ya que las lesiones pueden aparecer allí inicialmente.
- **Columna Cervical (Perfil, Máxima Flexión):** Se solicita para observar si existe **subluxación atlanto-axoidea anteroposterior**, una complicación mecánica grave.
- **Otras articulaciones comprometidas.**

II. Pronóstico y Causa de Muerte

La AR es una **enfermedad grave** que compromete la calidad de vida y aumenta la mortalidad. La mortalidad es **2 veces mayor** que la población general.

Causa Principal de Posible Muerte

La causa de muerte más importante es la **enfermedad cardiovascular**.

- El aumento de la mortalidad se debe, en parte, a la **aterosclerosis acelerada** y el **mayor riesgo cardiovascular**, siendo responsable de hasta el **50% del incremento de la mortalidad** en pacientes con AR. Las infecciones también constituyen una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad.

III. Síndromes Específicos de la AR

El desarrollo de manifestaciones extraarticulares se relaciona, en general, con la **seropositividad** (FR elevado) y la gravedad de la enfermedad.

Síndrome de Felty

Es una manifestación hematológica infrecuente de la AR, que se caracteriza por la tríada:

- **Artritis Reumatoidea (AR)** de larga data, seropositiva, nodular y deformante.
- **Esplenomegalia.**
- **Leucopenia** (Neutropenia).

Se asocia a úlceras cutáneas vasculíticas, neuropatía y mayor incidencia de infecciones a repetición.

Síndrome de Caplan

Es una manifestación pleuropulmonar rara de la AR.

- **AR + Nodulosis pulmonar + Neumoconiosis** (exposición a polvo mineral o similar).

IV. Síntomas Extraarticulares (¡Pregunta Clave!)

Las **manifestaciones extraarticulares** son un factor de mal pronóstico. Se asocian con mayor frecuencia a la positividad del Factor Reumatoideo.

Sistema	Manifestación Específica	Detalles Adicionales
Cutáneo	Nódulos Reumatoideos	Presentes en 20-25% de pacientes, suelen ser FR positivos y se encuentran en superficies extensoras (olécranon, tendón de Aquiles). Indican enfermedad más severa.
	Vasculitis Reumatoidea	Causa arteritis distal, hemorragias peri-ungueales, infartos digitales y úlceras cutáneas. Más frecuente en hombres con enfermedad avanzada y FR elevado.
Ocular	Queratoconjuntivitis seca (Ojo Seco)	Es la alteración ocular más común (10%). Otras: Epiescleritis, Escleritis, Escleromalacia perforante.

Pleuropulmonar	Derrame Pleural	Manifestación intratorácica frecuente, a menudo asintomática, puede tener alto contenido de Factor Reumatoide.
	Enfermedad Intersticial Pulmonar (EIP)	Puede evolucionar a fibrosis pulmonar.
Neurológico	Síndrome del Túnel Carpiano (STC)	Neuropatía por atrapamiento frecuente.
	Subluxación Atlantoaxoidea (AA)	Complicación temida que puede causar mielopatía cervical grave.
Sistémico/Renal	Amiloidosis (Tipo AA)	Se manifiesta como afección renal (proteinuria) y puede ser progresiva y mortal. Se observa en AR grave.
Hematológico	Anemia	Típicamente anemia normocítica de enfermedad crónica.

❌ **Importante:** La Uveítis anterior no se asocia típicamente a la AR seropositiva.

V. Tratamiento Farmacológico: Los Pilares

El tratamiento debe ser **agresivo** e iniciarse lo más temprano posible con el objetivo de lograr la remisión, reduciendo la destrucción articular y la mortalidad.

Drogas Modificadoras de la Enfermedad (DMARDs)

Son la **piedra angular del tratamiento** y deben usarse desde el momento del diagnóstico. El **Metotrexato (MTX)** es la droga de elección para iniciar la terapia.

Metotrexato (MTX) y Ácido Fólico

- **Dosis:** Inicial de **10 mg/semana** (o 7.5 a 25 mg/semana).
- **Escalada de Dosis:** Se recomienda una **escalada rápida y mensual** de 5 a 7.5 mg, hasta alcanzar la dosis máxima tolerada o **30 mg/semana** aproximadamente a los 2-3 meses.
- **Esquema Típico Inicial:** **Metotrexato 10 mg/semana** (con escalada rápida de dosis) + **Prednisona 5-10 mg/día + AINE a demanda.**
- **Uso de Ácido Fólico:** El MTX es un fármaco **antifólico** que inhibe la enzima dihidrofolato reductasa. La administración de MTX debe estar **asociada a ácido fólico** (o folínico) para **reducir los efectos secundarios** y la toxicidad (ej. gastrointestinal, estomatitis).
- **Contraindicación:** Categoría **X** en el embarazo. Se debe ajustar la dosis en casos de **insuficiencia renal** y está contraindicado en **hepatopatía grave.**

Otros DMARDs Tradicionales

Fármaco	Dosis Típica	Indicación Principal	Consideraciones Clave
Sulfasalazina (SFZ)	2 a 3 gr/día (Máximo 5000 mg/día).	Monoterapia en pacientes con contraindicación o intolerancia a MTX . Combinación (triple terapia).	Categoría B en el embarazo (No evidencia de riesgo).
Leflunomida (LEF)	20 mg/día.	Monoterapia en pacientes con contraindicación o intolerancia a MTX . También en combinación.	Categoría X en el embarazo .
Hidroxicloroquina (HCQ)	400 mg/día.	Uso restringido a la combinación con MTX y SFZ (triple terapia). No ha demostrado efecto sobre la progresión radiológica .	Categoría C en el embarazo (Riesgo por determinar).

Corticoides (Glucocorticoides)

Se utilizan para disminuir la inflamación, el dolor y el daño articular en los primeros años. Actúan como **terapia puente** mientras el DMARD (MTX) hace efecto.

- **Corticoides Principales: Prednisona.**
- **Dosis:** Baja, generalmente entre **5 y 10 mg de prednisona** al día.
- **Retiro/Duración:** Se deben usar entre **2 y 6 meses**. Se sugiere el **descenso rápido** de los mismos una vez alcanzado el control de la enfermedad debido al perfil de eventos adversos a largo plazo. Se pueden usar por **2 a 6 meses** (terapia puente).

AINEs (Antiinflamatorios No Esteroideos)

Se usan para reducir el **dolor y la inflamación**.

- **AINEs Principales Usados:** Diclofenac, Ibuprofeno, Naproxeno.
- **Inhibidores COX-2:** Celecoxib, Etoricoxib, tienen igual eficacia y menos trastornos gastrointestinales, pero pueden tener más riesgo cardiovascular (CV).
- **Uso:** Se utilizan **a demanda** (según necesidad) en el esquema inicial. Si la necesidad de AINEs es continua, debe interpretarse como un **control inadecuado de la actividad inflamatoria** y se debe replantear el régimen de DMARD.

Metáfora Final: Piensa en el tratamiento de la AR como la gestión de una inundación en un edificio:

- **Los AINEs y Corticoides** son las **cubetas y trapos** (reducen el síntoma inmediato - dolor/inflamación), son rápidos pero no detienen el origen.
- **Los DMARDs (como el Metotrexato)** son los **ingenieros que cierran la tubería rota** (alteran el curso de la enfermedad, evitan el daño estructural), son lentos en hacer efecto pero son la solución definitiva.
- **El Ácido Fólico** es el **chaleco de seguridad** que se le da al paciente para que no sufra la toxicidad del MTX. 🛠️💧

ESQUEMA TERAPÉUTICO DE LA ARTRITIS REUMATOIDEA (AR)

I. Manejo Farmacológico: Corticoides y DMARDs Convencionales

Efectos Adversos de los Corticoides (CS)

Los corticoides son la piedra angular del tratamiento en **fases iniciales** debido a su gran poder antiinflamatorio, utilizándose como **terapia puente** para disminuir la inflamación, el dolor y el daño articular en los primeros años, mientras los DMARDs hacen efecto. Sin embargo, su uso prolongado o en dosis altas conlleva numerosos riesgos, ya que la mayoría de los eventos adversos son una consecuencia directa de sus efectos fisiológicos.

Categoría	Efectos Adversos Comunes / Graves
Metabólicos y Endocrinos	Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo II o empeoramiento de glucemia, resistencia a la insulina, Síndrome de Cushing (dosis > 20 mg de prednisona), dislipemia.
Óseos y Musculares	Osteoporosis (dosis y tiempo dependiente), osteonecrosis (necrosis avascular), miopatía esteroidea.
Infecciosos	Aumento del riesgo de infección (riesgo dependiente de la dosis). Riesgo elevado de infecciones oportunistas (ej. fúngicas o por bacterias intracelulares) con dosis > 15 mg/día de prednisona o equivalente por más de 21 días.
Gastrointestinales	Úlcera péptica (mayor riesgo si se asocia a AINEs).
Psiquiátricos/Anímicos	Cambios en el humor, disturbios psicológicos, psicosis.
Otros	Cataratas, glaucoma, atrofia cutánea, insuficiencia adrenal si se suspende bruscamente, riesgo cardiovascular aumentado.

Efectos Adversos Comunes de los DMARDs Convencionales (FAMEsc)

Las **Drogas Antirreumáticas Modificadoras de la Enfermedad (DMARDs)** constituyen la base del tratamiento y deben usarse desde el momento del diagnóstico.

- **Riesgo de Infección:** El uso de **Metotrexato (MTX)** y otras DMARDs (Sulfasalazina, Leflunomida, Hidroxicloroquina) se asocian a un **mayor riesgo de infección por Virus Herpes Zoster**. El uso concomitante de corticoides incrementa este riesgo.
- **Toxicidad Hepática y Gastrointestinal:** La toxicidad hepática (elevación de transaminasas) y los síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) son efectos adversos comunes que requieren monitorización estricta para MTX, Sulfasalazina y Leflunomida.
 - **Metotrexato:** La toxicidad menor incluye náuseas, vómitos, alopecia, estomatitis y elevación de transaminasas. La toxicidad severa (neumonitis, fibrosis hepática o mielosupresión) es menos frecuente pero grave.
 - **Leflunomida:** Causa frecuentemente diarrea, hipertensión arterial y toxicidad hepática.
 - **Sulfasalazina:** Causa náuseas, vómitos, dolor abdominal y alteraciones del hepatograma.

Seguimiento por Laboratorio para DMARDs (Monitorización de Toxicidad)

La monitorización es clave para detectar la toxicidad, especialmente la **mielosupresión** y la **hepatotoxicidad**.

DMARD	Monitoreo Basal	Monitoreo Posterior Típico	Indicación de Suspensión
Metotrexato	Hemograma completo, Función Hepática y Renal, serología VHB y VHC, Rx de tórax.	Mensual hasta dosis deseada, luego cada 2 o 3 meses .	Elevación de transaminasas superior a 3 veces el valor máximo.
Sulfasalazina	Hemograma completo, Función Hepática (considerar dosaje de G6PD).	Mensual los primeros 4 a 6 meses, luego cada 2 a 3 meses.	Enfermedad hepática o hematológica severa.
Leflunomida	Tensión arterial, Hemograma completo, Función Hepática y Renal, serología VHB y VHC.	Mensual los primeros seis meses, luego cada dos meses.	Si la elevación de transaminasas es superior a 3 veces el valor máximo.
Hidroxicloroquina	Hemograma y Examen Oftalmológico .	Control oftalmológico cada seis meses .	Retinopatía preexistente.

II. Estrategia "Tratar Hacia el Blanco" (Treat to Target) 🎯

La estrategia de tratamiento en AR se basa en un **monitoreo estricto y periódico** de la actividad de la enfermedad, ajustando el tratamiento hasta lograr el objetivo.

📅 Tiempos de Evaluación y Escalada Terapéutica

Pregunta	Respuesta Clave
¿A las cuántas semanas se evalúa el Tto?	El monitoreo de la actividad (usando índices compuestos como el DAS28) debe realizarse de forma estricta y periódica, idealmente cada 1 a 3 meses . Se recomienda realizar el DAS28 cada tres meses .
¿Cuántas semanas tarda el DARME en hacer efecto?	Los corticoides se usan como terapia puente en espera de que el efecto de los DMARDs se inicie. Aunque no se especifica un tiempo exacto para todos los DMARDs, la respuesta clínica a los 3 meses predice la respuesta a 1 año.
¿A las cuántas semanas evaluamos para dar un segundo DMARD?	Si no se logra la remisión en 12 semanas (3 meses), se debe adicionar un segundo DMARD. La respuesta clínica a los 3 meses predice el pronóstico.

Criterios para dar un segundo DMARD	El objetivo es lograr la Remisión o, al menos, la Baja Actividad . Si el paciente está solo con Metotrexato y no logra la remisión en 12 semanas , se adiciona un segundo DMARD.
--	---

Grados de Actividad de la Enfermedad (DAS28)

El DAS28 es uno de los índices compuestos más utilizados para monitorizar la actividad de la AR.

- **Remisión:** < 2.6.
- **Baja Actividad:** 2.6–3.2.
- **Actividad Moderada:** 3.2–5.1.
- **Alta Actividad:** > 5.1.

III. Factores de Mal Pronóstico e Intensificación del Tratamiento

► Criterios de Mal Pronóstico y Agresividad Terapéutica

Los **Factores de Mal Pronóstico (FMP)** identifican a los pacientes en los que se debe ser más agresivo con el tratamiento, a menudo indicando un tratamiento combinado desde el inicio.

Factor de Mal Pronóstico	Descripción
Serología	Valores elevados de Anti-CCP. Factor Reumatoideo (FR) positivo (especialmente títulos altos).
Actividad Inflamatoria	Persistencia de VSG y PCR elevadas (actividad inflamatoria elevada).
Daño Estructural	Detección precoz de erosiones radiológicas .
Compromiso Articular	Compromiso de articulaciones de las manos o compromiso de dos o más grandes articulaciones .
Tiempo de Evolución	Retraso en el inicio del tratamiento (ventana síntomas a diagnóstico mayor a 6 meses).
Otros	Grados elevados de discapacidad (HAQ), presencia de manifestaciones extraarticulares, sexo femenino y bajo nivel socioeconómico.

Indicación de Dosis más Altas/Terapia Combinada: En pacientes con **factores de mal pronóstico**, como valores elevados de CCP o diagnóstico tardío, se debe indicar tratamiento combinado (adicionar un segundo DMARD). Para el Metotrexato, se recomienda optimizar la

dosis con una **escalada rápida y mensual** de la droga hasta **30 mg por semana** o dosis máxima tolerada.

IV. Terapia Biológica y Esquema Terapéutico Completo

🌟 Criterios para Indicar una Terapia Biológica

Los agentes biológicos (FAMEb) han demostrado gran eficacia, y su indicación se reserva para casos que no logran la remisión con DMARDs convencionales.

1. **Falla a DMARDs Convencionales:** Pacientes con **AR activa** que **no han respondido** en un tiempo adecuado (**3 a 6 meses**) al tratamiento con **Metotrexato solo** (a dosis máximas, hasta 25 mg/semana). Generalmente, se indican en pacientes que **no responden al menos a dos DMARDs, uno de los cuales debe ser Metotrexato**.
2. **Actividad Persistente:** Se consideran para enfermedad activa ($DAS\ 28 > 5.1$). Sin embargo, la indicación **NO debe limitarse solo a $DAS28 \geq 5.1$** , ya que hay pacientes con actividad persistente que no alcanzan ese valor.
3. **Intolerancia/Contraindicación:** En casos de **hepatotoxicidad o mielotoxicidad** a DMARDs, o cuando existe una **contraindicación formal para los DMARDs**.

Nota: **No es necesario** que un paciente reciba cursos de otras DMARDs (Sulfasalazina, Hidroxicloroquina, Leflunomida, etc.) antes de iniciar un agente anti-TNF si el MTX falla.

🚫 Contraindicaciones de la Terapia Biológica (Anti-TNF α)

Las contraindicaciones principales, especialmente para los anti-TNF α , son:

1. **Infecciones Activas o Latentes:** Esto incluye la **Tuberculosis (TBC)** no tratada.
2. **Enfermedad Desmielinizante.**
3. **Insuficiencia Cardíaca** (grados II-IV).
4. **Enfermedad Oncológica** en los últimos 5 años.

🛡️ Profilaxis y Estudios Previos a la Terapia Biológica

Antes de iniciar cualquier terapia biológica, se deben realizar estudios y profilaxis para prevenir la reactivación de infecciones latentes.

Estudios de Cribado (Screening) **Obligatorios:**

- **Tuberculosis Latente:** Se debe hacer un **despistaje de tuberculosis latente**. Esto incluye realizar:

- **PPD** (tuberculina) ≥ 5 mm.
- **Radiografía de tórax** (para descartar TBC previa o anormalidades compatibles).
- **Hepatitis B y C:** Serología para virus B y C. Si hay riesgo de reactivación de Hepatitis B, se recomienda **profilaxis con antirretrovirales** (ej. Entecavir o Tenofovir).
- **Otros estudios sugeridos:** Serología para **VIH**, anticuerpos antinucleares (ANAs), anti-ADN, anticardiolipinas (aCL) y test de embarazo.

Vacunación Recomendada:

Los pacientes con AR tienen indicación de vacunación contra:

- **Vacuna contra Influenza (Gripal).**
- **Vacuna Antineumocócica.**
- **Vacunas Inactivadas:** Pueden administrarse durante la terapia biológica.
- **Vacunas a Virus Vivos Atenuados:** Están **contraindicadas** en pacientes que reciben agentes biológicos. Idealmente, deben administrarse **4 semanas antes** de comenzar el tratamiento con Tocilizumab, y si se requiere durante el tratamiento, debe suspenderse la droga **70 días antes** (5 vidas medias).



Evaluación de la Respuesta a la Terapia Biológica

El tratamiento con anti-TNF α debe continuarse **solo si se logra una respuesta adecuada**.

- La respuesta adecuada se evalúa a los **3 a 6 meses** de iniciado el tratamiento.
- Se considera **respuesta adecuada** a una **mejoría del DAS28 $\geq 1,2$** con respecto al valor basal.

El esquema terapéutico completo de la AR, por lo tanto, es un proceso dinámico de ensayo y error controlado, donde la vigilancia clínica y de laboratorio constante (monitorización estricta cada 1-3 meses) es tan vital como la elección inicial de la droga para evitar la progresión de la enfermedad y el daño crónico.



OSTEOPOROSIS: LA ENFERMEDAD SILENCIOSA DEL ESQUELETO

I. ¿Qué es la Osteoporosis y su Fisiopatogenia Básica?



Concepto y Desbalance Óseo

La **Osteoporosis** es una enfermedad esquelética caracterizada por una **ruptura en el balance entre la formación y la resorción ósea**. Esto conduce a una **disminución de la masa ósea** y una alteración en la **calidad del hueso**, lo que aumenta significativamente el riesgo de fracturas. Se estima que entre el **50-60% de las mujeres postmenopáusicas** padecerán OP.



Fisiopatogenia Básica: El Balance Negativo

El hueso está en constante renovación a través de unidades de remodelación ósea (BRU), mediadas por **Osteoclastos (OC)** que destruyen y **Osteoblastos (OB)** que forman hueso.

- **Pico de Masa Ósea:** Se alcanza alrededor de los **30 a 35 años**.
- **Pérdida Fisiológica:** Después del pico, hay una pérdida anual de aproximadamente 1-2%.
- **Aceleración Postmenopáusica:** Tras la menopausia (por la **depleción de estrógenos**), la pérdida de masa ósea se acelera drásticamente, llegando al **4-7% anual**.
- **Balance Negativo:** La pérdida se produce porque la cantidad de hueso formada por los OB es menor que la destruida por los OC (balance negativo de las BRU). Este proceso resulta en el **adelgazamiento y la desaparición de las trabéculas** en el hueso trabecular y el adelgazamiento de la cortical.

II. Factores de Riesgo y Medicamentos Causales



Factores de Riesgo que Más la Provocan

Los factores de riesgo son muy numerosos, pero algunos tienen una asociación más fuerte:

1. **Hormonales / Involutivos:**
 - **Sexo Femenino y Edad Avanzada** (principales).

- **Hipoestrogenismo y Menopausia precoz** (< 40 años).
- **Hipogonadismo** en ambos sexos.
- 2. **Constitucionales:**
 - **Índice de Masa Corporal (IMC) bajo** (≤ 19 o menor a 21).
 - **Antecedentes familiares** de fractura en padres.
- 3. **Estilo de Vida (Modificables):**
 - **Tabaquismo y Alcoholismo** excesivo.
 - **Sedentarismo.**
 - **Baja ingesta de calcio y Déficit de vitamina D.**
- 4. **Enfermedades Asociadas (OP Secundaria):**
 - **Artritis Reumatoidea (AR).**
 - **Hipercortisolismo y Hipertiroidismo.**
 - **Mieloma o Leucemia.**
 - Enfermedades de malabsorción.

Medicamentos que Pueden Causar Osteoporosis

La Osteoporosis Inducida por **Glucocorticoides** (OIC) es la forma secundaria más común y clara.

Fármaco	Efecto Adverso Principal Relacionado
Glucocorticoides / Corticoides	Inhiben la formación ósea y aumentan la resorción. Efecto tóxico evidente con 2.5 mg de prednisona/día por > 3 meses.
Anticoagulantes	Fármacos como la heparina (uso a largo plazo).
Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP)	Fármacos como el Omeprazol.
Diuréticos	Específicamente, los diuréticos de asa (aumentan la excreción renal de calcio).
Anticonvulsivos	Fármacos antiepilépticos (aumentan el catabolismo de la Vitamina D).
Antiestrógenos / Antiandrógenos	Fármacos utilizados en cáncer, que inducen un estado de hipogonadismo.

III. Diagnóstico: Densitometría y Criterios

DXA: La Herramienta de Diagnóstico

El diagnóstico de la Osteoporosis se establece mediante la **Densitometría Ósea (DMO)** por absorciometría de rayos X de doble energía (DXA).

Criterios Específicos de la DMO y Sitios Alcahuete

La DMO se expresa en **T-score** (comparación con el pico de masa ósea de adultos jóvenes) y **Z-score** (comparación con personas de la misma edad y sexo).

- **Sitios de Medición (DXA):**
 1. **Columna Lumbar:** Se utiliza la media de al menos **dos vértebras contiguas** para el diagnóstico.
 2. **Cuello Femoral o Fémur Proximal:** Se utiliza el valor **menor** (el más bajo) de estas regiones.
 3. **Radio Distal** (en ciertos casos).
- **Criterios de Clasificación (T-score):**
 - **DMO Normal:** T-score ≥ -1.0 DE.
 - **Osteopenia:** T-score entre **-1.0 y -2.5** DE.
 - **Osteoporosis:** T-score < -2.5 DE.
 - **Osteoporosis Establecida:** Osteoporosis (< -2.5 T) **acompañada de fractura**.

Indicaciones para Solicitar DMO

La DMO está indicada en:

- **Mujeres de edad igual o mayor a 65 años y hombres de edad igual o mayor a 70 años.**
- Mujeres postmenopáusicas con factores de riesgo.
- Pacientes que utilizan **corticoides** (2.5 mg/día o más de prednisona o equivalente) por **más de 3 meses**.

Hallazgos en la Radiografía (Rx)

La radiología simple es **poco sensible** (requiere una pérdida de masa ósea del 30-40% para ser evidente). Se usa principalmente para detectar fracturas:

- **Apariencia Ósea:**
 - **Vértebra en Lluvia:** Disminución de la visibilidad de las trabéculas horizontales con aumento de las verticales.
 - **Vértebra Vacía:** Refuerzo de los platillos vertebrales, junto con menor densidad del cuerpo vertebral.
 - **Cortical Delgada:** Adelgazamiento anormal de la cortical en huesos tubulares.
- **Fracturas Típicas:** Fracturas vertebrales (acuñamiento, biconcavidad o **vértebra de pez**). Las fracturas vertebrales por OP **prácticamente nunca se producen por encima de D4** ni en la columna cervical.

IV. Hipercalcemia Primaria y Tratamiento

☀️ Causas de Hipercalcemia Primaria (No Neoplásica)

La **Hipercalcemia** (Calcio sérico total > 10.5 mg/dL) es la manifestación de un trastorno del metabolismo calcio-fósforo.

1. **Hiperparatiroidismo Primario (HPP):** Es la **causa más frecuente** de hipercalcemia en el ámbito ambulatorio.
 - Se produce por la secreción inapropiada o elevada de la Hormona Paratiroidea (PTH), generalmente por un **adenoma único** (80-85%).
 - La hipercalcemia resultante es incapaz de suprimir la secreción aumentada de PTH.
2. **Otras Causas No Malignas Destacadas:**
 - **Intoxicación por Vitamina D** (colecalfiferol o calcidiol).
 - **Enfermedades Granulomatosas** (ej. Sarcoidosis), por síntesis extrarrenal de calcitriol.
 - **Fármacos:** Uso de **Litio** o **Diuréticos Tiazídicos**.
 - **Hipertiroidismo** (10-20% de los pacientes).

⚖️ Tratamiento de la Osteoporosis y la Osteopenia

El tratamiento busca **lograr la remisión** o, al menos, la baja actividad en las enfermedades inflamatorias que la causan. Sin embargo, en la OP, el objetivo es **prevenir fracturas adicionales**.

🟢 Tratamiento de la Osteopenia (T-score entre -1.0 y -2.5)

El manejo de la Osteopenia ($DMO < -1.0$ y > -2.5 T) se centra en medidas basales y prevención.

1. **Bases:** Asegurar **Calcio elemental (1000-1500 mg/día)** y **Vitamina D (800-1200 UI/día)**, ejercicio y eliminación de hábitos tóxicos.
2. **Farmacológico:** **NO se utilizan bifosfonatos** de forma rutinaria. El tratamiento solo está justificado en pacientes con osteopenia que presenten **factores de riesgo fuertemente asociados a fracturas** (ej. AR, antecedente familiar de fractura) o en pacientes con **corticoterapia prolongada (OIC)**.

🟠 Tratamiento de la Osteoporosis (T-score < -2.5 o fractura)

1. **Esquema Inicial (Primera Línea):**

- **Calcio y Vitamina D:** 1000-1200 mg de calcio elemental y 800-1000 UI/día de Vitamina D.
- **Bifosfonatos:** Son la primera elección. Se prefieren **Alendronato (70 mg/semana VO)** o **Risedronato**. En caso de problemas de adherencia o intolerancia oral, **Zoledronato (5 mg/año IV)**.
- **Denosumab:** (60 mg s.c. cada 6 meses) es una alternativa de primera línea, especialmente si hay insuficiencia renal ($FG < 30 \text{ mL/min}$), aunque debe vigilarse la hipocalcemia.

2. Modificación del Esquema (Casos Graves):

- **Criterio de Gravedad:** Pacientes con **dos o más fracturas vertebrales**.
- **Terapia Osteoformadora:** Se recomienda iniciar con un análogo de la PTH, como la **Teriparatida** (fragmento 1-34, $20 \mu\text{g/día s.c.}$) por un máximo de **2 años**.
- **Secuencia:** Tras finalizar la Teriparatida (que es costosa y limitada en tiempo), se debe **continuar con un tratamiento antirresortivo** (bifosfonatos o Denosumab) para mantener la masa ósea ganada.

3. Retiro del Tratamiento (Vacaciones Terapéuticas):

- Se puede considerar retirar los bifosfonatos (Alendronato/Risedronato) después de **5 años** de tratamiento, o Zoledronato después de **3 años**, si la DMO está por encima de -2.5 T y no ha habido fracturas.
- El **Denosumab** no debe suspenderse abruptamente sin una transición, ya que su retiro produce un aumento brusco del recambio óseo que puede causar fracturas vertebrales múltiples.

Analogía Final: La osteoporosis es como un edificio cuya estructura se va carcomiendo lentamente por dentro. Los **Bifosfonatos y Denosumab** son el "cemento" que frena la destrucción y evita que se caigan las paredes. La **Teriparatida** es como construir una **nueva viga de soporte** (formación ósea) en las áreas críticas, pero una vez construida esa viga, necesitas volver a aplicar el "cemento" para mantenerla fuerte. 🏗️

💜 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES): UN DESAFÍO AUTOINMUNE 💜

📖 I. Concepto y Criterios de Clasificación

El LES es una **enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica** de etiología multifactorial. Su base fisiopatológica es la **hiperproliferación de linfocitos B** y la supresión de linfocitos T, especialmente CD8+.

📖 Criterios de Clasificación EULAR/ACR 2019

El diagnóstico del LES es fundamentalmente clínico. Para la clasificación (usada para homogeneizar pacientes en ensayos clínicos) se utilizan los criterios EULAR/ACR 2019, que son los más recientes y exigen dos elementos:

1. **Criterio Obligatorio: Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos a título > 1:80** sobre células HEp-2 o equivalente. Si es negativo, no se puede clasificar como LES.
2. **Puntuación Adicional:** Se precisan **10 o más puntos adicionales** provenientes de dominios clínicos e inmunológicos (como nefritis lúpica clase III o IV que otorga 10 puntos, o anti-DNA ds o anti-Sm que otorgan 6 puntos).

❓ ¿Qué se evalúa con los Criterios ACR?

El ACR (American College of Rheumatology) propone criterios que evalúan múltiples dominios:

Dominio Evaluado	Criterios Clínicos e Inmunológicos
Cutáneo/Mucoso	Eritema malar, erupción discoide, fotosensibilidad, aftas orales/nasales no dolorosas.
Articular	Artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas.
Serosas	Pleuritis o Pericarditis.
Renal	Proteinuria > 0.5gr/24h o cilindros hemáticos.
Neurológico	Psicosis o Convulsiones.
Hematológico	Anemia hemolítica, Leucopenia (< 4000/mm ³), Linfopenia (< 1500/mm ³), Trombocitopenia (< 100.000/mm ³).

Inmunológico	Anti-DNA (título anormal), Anti-Sm, Hallazgo positivo de Anticuerpos Antifosfolipídicos (AFL), ANA positivo.
---------------------	--

II. Autoanticuerpos: El Perfil Serológico Lúpico

Los autoanticuerpos son fundamentales para el diagnóstico y el pronóstico.

Anticuerpo	Prevalencia (%)	Valor Clínico y Asociación Clave
Anticuerpos Antinucleares (ANA)	> 95%	Necesarios para la clasificación. No son específicos del LES.
Anti-dsDNA (Doble Hebra)	Hasta 70%	Muy alta especificidad. Fuerte asociación con compromiso renal y neurológico . Son marcadores de actividad de la enfermedad.
Anti-Sm (Smith)	10-30%	Altamente específico de LES (95-100% de especificidad) pero de baja sensibilidad.
Anti-Ro (SS-A) y Anti-La (SS-B)	20-50%	Asociados a Lupus Neonatal (riesgo de Bloqueo AV Congénito), lupus cutáneo subagudo (LCSA) y fotosensibilidad .
Antifosfolipídicos (AFL)	Hasta 50%	Asociados a fenómenos trombóticos (venosos y arteriales), pérdidas fetales recurrentes y Valvulopatía de Libman-Sacks . Pueden dar VDRL falsa positiva .
Anti-Histonas	Específicos de...	Lupus inducido por drogas.

III. Clínica Típica y Lesiones Específicas

Las manifestaciones cutáneas se presentan hasta en el **80% de los pacientes**.

Manifestaciones Cutáneas Clave

Tipo de Lesión Específica	Característica Principal	¿Deja Cicatriz?
Aguda: Rash Malar (Alas de Mariposa)	Placa eritematosa en región malar y puente nasal, a menudo tras fotoexposición.	No deja secuelas (salvo telangiectasias).
Subaguda: Placas Psoriasiformes/Anulares	Exantema papular eritematoso de zonas fotoexpuestas.	No deja secuelas.

Crónica: Rash Discoide	Placa eritematosa sobre los hombros, con tapones foliculares.	Deja cicatriz permanente (atrofia).
-------------------------------	---	--

Manifestaciones Musculoesqueléticas

La **artritis/artralgia** es la **forma de presentación más común**. Es una **poliartritis** **simétrica** y **no erosiva**. Puede haber deformidad articular sin erosión, conocida como **Artropatía de Jaccoud** (desviación cubital).

Manifestaciones Generales y Serosas

- **Generales:** Fiebre sin focalidad, astenia, y fatiga.
- **Serositis:** La **pericarditis** es la afectación cardíaca más frecuente (25-40% de los pacientes). El **derrame pleural** es muy frecuente y no es raro que sea la primera manifestación.

IV. Complicaciones Más Frecuentes y Tipo de Daño

La afectación de ciertos órganos se asocia a un **peor pronóstico** y define la morbilidad y mortalidad.

Complicación / Afectación	Tipo de Daño o Lesión Generada	Pronóstico / Relevancia
Nefritis Lúpica (NL) (Afecta > 70%)	Lesión glomerular por depósito de inmunocomplejos (IC) , Igs y Complemento. Proteinuria y/o hematuria .	Factor de pronóstico desfavorable . Marcan el pronóstico de la enfermedad.
Neuropsiquiátrico	Convulsiones, psicosis, mielitis, accidente cerebrovascular (ACV) , disfunción cognitiva.	Factor de pronóstico desfavorable . A menudo asociado a SAF .
Cardiovascular	Aterosclerosis acelerada y Valvulopatía de Libman-Sacks (inflamación valvular estéril).	Principal causa de mortalidad en mayores de 60 años.
Hematológico	Anemia hemolítica autoinmune , leucopenia, linfopenia, trombocitopenia.	Las citopenias leves remiten con tratamiento básico.
Osteonecrosis Avascular	Destrucción ósea que afecta más frecuentemente caderas y rodillas .	Causada por enfermedad activa o uso crónico de corticoides .

Causa de Muerte

Las principales causas de mortalidad son las **infecciones oportunistas**, la propia enfermedad, y las **complicaciones cardiovasculares** (en pacientes mayores).

V. Tratamiento: Esquemas Típicos y Fármacos Esenciales

El tratamiento es individualizado, orientado a la remisión y la prevención de brotes.

Pilares del Tratamiento (Tratamiento Básico)

El tratamiento básico (SOC: *Standard of Care*) incluye:

1. **Educación del Paciente** y protección solar (evitar luz UV).
2. **Antipalúdicos (AM): Hidroxicloroquina (HCQ)** (400 mg/día).
 - **Uso:** Debe ser recibido por **todos los pacientes** con LES, excepto contraindicación.
 - **Beneficio:** Retrasa la aparición de **enfermedad renal**.
3. **Corticoides (GC):** Son la **piedra angular del tratamiento**.
 - **Dosis:** Dependen de la manifestación (bajas < 10 mg/día para síntomas constitucionales/artritis; altas o pulsos para afectación orgánica grave).
4. **AINEs:** Se utilizan a demanda para síntomas constitucionales.
 - **Advertencia:** El **Ibuprofeno está contraindicado** por riesgo de **meningitis aséptica**. No usar COX 2 selectivos si hay Síndrome Antifosfolípido (SAF) asociado.

Esquema de Tratamiento para Afectación Grave (Nefritis Lúpica)

El tratamiento para Nefritis Lúpica (GNF tipo III, IV o V) y compromiso Neuropsiquiátrico grave se divide en Inducción y Mantenimiento.

- **Inducción:** Típicamente consiste en **pulsos de corticoides** (1 g/día de metilprednisolona i.v. por 3 días) seguidos de **Micofenolato Mofetilo (MMF)** (2 g/día). La Ciclofosfamida se utiliza como alternativa o para casos refractarios.
- **Mantenimiento:** Azatioprina (2-3 mg/Kg/día) o MMF.

VI. Fármacos que Causan Lupus Inducido por Drogas (LID)

El LID tiene una clínica similar al LES, pero con un perfil de órgano distinto y serología característica.

- **Clínica:** Las **manifestaciones cutáneas y pulmonares son más frecuentes**, y las **renales y neurológicas son más raras**.
- **Serología Característica:** Se asocia a **ANA positivos** y **Antihistonas positivos**, con autoanticuerpos específicos (anti-dsDNA, anti-Sm) negativos.
- **Remisión:** El cuadro remite al **suspender la droga**, aunque la recuperación completa puede tardar hasta un año.
- **Ejemplos de Fármacos Causales:** Procainamida, Hidralazina, Metildopa, Isoniazida, Fenitoína, Carbamazepina, Quinidina, Minociclina y Sulfasalazina.

VII. Diagnóstico y Tratamiento en Embarazadas

El embarazo en mujeres con LES es considerado de **alto riesgo**.

➤ Diagnóstico y Seguimiento en Gestación

1. **Recomendación Clave:** La gestación debe ser **programada en un período de remisión** de la enfermedad de **al menos 6 meses**.
2. **Complicación Frecuente:** El **Parto Prematuro (PP)** es la complicación más común, especialmente si hay Nefritis Lúpica activa al inicio.
3. **Seguimiento Fetal (Bloqueo AV):** Si la madre es **Anti-Ro positiva (30-50%)**, existe riesgo de Lupus Neonatal y **Bloqueo Cardíaco Congénito (BCC)**, que es permanente.
 - Se requiere **monitorización ecocardiográfica fetal** para detectar la alteración precozmente, generalmente entre las **18 y 32 semanas** de gestación.

Tratamiento y Profilaxis en el Embarazo

- **Antipalúdicos (HCQ):** Se pueden **continuar durante el embarazo y la lactancia**. Su uso es recomendado.
- **Fármacos Seguros:** La **Azatioprina (2-3 mg/Kg/día)** es considerada segura en el embarazo y puede usarse para mantenimiento. La Sulfasalazina también se considera de Categoría B.
- **Profilaxis para Bloqueo AV Congénito (BCC):**

- Para intentar frenar la progresión del bloqueo (de Grado I o II a completo), se utiliza **dexametasona** o inmunoglobulinas i.v..
 - Específicamente, se menciona la **profilaxis/tratamiento con dexametasona** para el feto. Es importante notar que los glucocorticoides fluorados como la dexametasona se utilizan para llegar al feto, aunque los estudios sobre su efectividad son debatibles, y una fuente indica que la dexametasona se usa bajo la premisa (errónea en farmacología general, pero citada textualmente) de que "no atraviesa la barrera placentaria".
 - **SAF en Embarazo:** En mujeres embarazadas con SAF y pérdidas recurrentes, se sugiere usar **Hidroxicloroquina (HCQ)** más **Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM)** más **Aspirina a Dosis Bajas (LDA)**, sobre otras combinaciones.
-

En resumen: La gestión del LES es un acto de equilibrio donde los **Antipalúdicos** son la base universal, los **Corticoides** manejan la crisis aguda y los **DMARDs/Inmunosupresores** (principalmente MMF/AZA) evitan el daño orgánico crónico, especialmente en la Nefritis Lúpica. La presencia de **Anti-dsDNA** y la afectación **renal/neurológica** marcan la pauta del tratamiento más agresivo, mientras que el **Anti-Ro** dicta una vigilancia fetal rigurosa. ✨

🧑‍🦲 ARTROSIS (OA): EL DESGASTE DEL APARATO LOCOMOTOR 🛠️

I. Concepto y Fisiopatogenia Básica

La artrosis no se describe como una única enfermedad, sino como un trastorno que afecta a las **articulaciones móviles**.

- **Definición:** Se caracteriza por el **estrés celular** y la **degradación de la matriz extracelular del cartílago**, lo que conlleva alteraciones en la articulación, incluyendo degradación del cartílago, remodelación ósea, formación de osteófitos e inflamación articular.
- **Lesión Fundamental:** El mecanismo lesivo fundamental es la **degradación del cartílago**.
- **Componentes Afectados:** La rodilla osteoarthrítica, por ejemplo, presenta una **cápsula engrosada**, **esclerosis en el hueso subcondral**, **hipertrofia sinovial**, **formación de osteófitos** y fibrosis del cartílago.

💔 II. Características del Dolor: La Diferencia Clave con la Artritis

El dolor es el síntoma más frecuente en la artrosis. La distinción entre dolor **mecánico** (Artrosis) e inflamatorio (Artritis) es fundamental para el diagnóstico diferencial.

📄 Dolor de Naturaleza Mecánica (Artrosis)

El dolor en la artrosis es de "**función mecánica**".

Característica	Artrosis (Mecánico)	Diferencia con Artritis (Inflamatorio)
Relación con el Movimiento	Aparece o se exacerba al iniciar el movimiento o con el uso de la articulación.	En la artritis, el dolor es continuo y persiste en reposo .

Reposo	Cede o disminuye de forma muy acentuada con el reposo.	La artritis se caracteriza por dolor que persiste en reposo (dolor inflamatorio).
Rigidez Matutina	Es corta . Dura menos de 30 minutos .	La rigidez matutina en la Artritis Reumatoidea dura más de 1 hora .
Reactantes de Fase Aguda (VSG/PCR)	No se evidencia elevación de los parámetros que analizan la reacción de fase aguda.	En la artritis, los reactantes de fase aguda están elevados .

¡**Dato Clave!** A medida que la artrosis progresa, el dolor puede volverse **más continuo**, apareciendo en reposo e incluso por la noche.

III. Articulaciones y Causas Frecuentes

La artrosis es la enfermedad reumática más prevalente, con una prevalencia en España de entre el 3% y el 26%.

Localizaciones Típicas

- **Manos: Interfalángicas Proximales (IFP) e Interfalángicas Distales (IFD)** (Nódulos de Heberden en IFD y Bouchard en IFP). También la primera carpometacarpiana.
- **Grandes Articulaciones de Carga: Rodilla y Cadera.**
- **Columna Vertebral:** Artrosis vertebral (espondiloartrosis).

Causas Frecuentes y Factores de Riesgo

La artrosis se clasifica clásicamente en **primaria o idiopática** y **secundaria** a procesos asociados.

Factor de Riesgo	Detalle / Relevancia
Edad Avanzada	La correlación no es lineal, el incremento es exponencial a partir de los 50 años .
Obesidad	Es un factor que contribuye al riesgo, especialmente en la rodilla y la cadera. El riesgo es 4 a 4.8 veces mayor en personas obesas.
Sexo	A partir de los 55 años, la enfermedad afecta de modo significativo a las mujeres , siendo más grave y afectando a más articulaciones.

Traumatismos/Actividad Laboral	Actividad física de competición y profesiones que obligan a flexionar frecuentemente la rodilla (albañiles, bomberos).
Otros Factores	Condrocálculos, alteraciones en la alineación articular (genu varum, genu valgum), y factores genéticos.

IV. Diagnóstico (Dx)

El diagnóstico se establece a partir de los **datos clínicos** (dolor mecánico) y la **imagen radiológica**.

1. Hallazgos Radiológicos Clásicos (Rx)

La radiografía simple es la base del diagnóstico de artrosis consolidada. Los signos clásicos radiológicos son:

- **Disminución del Espacio Articular (Pinzamiento):**.
- **Osteófitos:** Crecimiento del hueso en los márgenes articulares.
- **Esclerosis Subcondral:** Aumento de la densidad ósea bajo el cartílago.
- **Quistes.**

Importante: La artrosis **no** determina alteraciones en los parámetros hematológicos, bioquímicos ni en los **reactantes de fase aguda (VSG, PCR)**.

2. Líquido Sinovial (LS)

El líquido sinovial en la artrosis presenta características **no inflamatorias (Tipo I)**:

- Es **viscoso** y **no turbio**.
- El número de células es **inferior a 2.000/μL**.
- Siempre se debe analizar con microscopio de luz polarizada para descartar cristales (ej. pirofosfato cálcico).

3. Densitometría Ósea (DMO)

La DMO permite evaluar el estado de la densidad mineral ósea. La existencia de **osteopenia** por sí misma **no constituye una indicación terapéutica** para OP, salvo que se añada algún factor de riesgo fuertemente asociado a fractura (por ejemplo, artritis reumatoide).

V. Tratamiento (Tto)

El tratamiento de la artrosis debe ser **individualizado** y tiene como objetivos: **controlar el dolor, mantener la funcionalidad y reducir al máximo la progresión**. Se distinguen dos estrategias: modificadores del síntoma (rápidos o lentos) y modificadores de la estructura (DMOAD).

1. Tratamiento No Farmacológico (Mandatorio)

Se debe educar al paciente, haciendo énfasis en los factores de riesgo modificables.

- **Pérdida de Peso:** La disminución del peso en pacientes obesos **reduce los síntomas y retrasa la destrucción del cartilago**.
- **Ejercicio Físico:** El ejercicio aeróbico y el **fortalecimiento de la musculatura proximal** (ej. cuádriceps) son beneficiosos.
- **Medidas de Apoyo:** Uso de bastón, calzado adecuado, y aplicación de calor/frío.

2. Fármacos Modificadores de los Síntomas

Analgésicos y AINEs

- **Analgésicos:** Muchas guías recomiendan paracetamol como primera línea, aunque su uso es controvertido por su pequeño efecto.
- **AINEs:** Son de **segunda línea**. No hay evidencia de que un AINE sea mejor que otro, pero el **naproxeno** parece tener mejor perfil de seguridad cardiovascular. Se deben utilizar con **extrema precaución** debido a los efectos secundarios gastrointestinales, cardiovasculares y renales.

Glucocorticoides

- La administración **sistémica NO está indicada**.
- La **infiltración intraarticular** es una opción eficaz, especialmente para el tratamiento de la **sinovitis aguda** o cuando el paciente está en espera de cirugía.

Fármacos de Acción Lenta (SYSADOA)

- Incluyen el **Sulfato de Glucosamina (1500 mg/día)** y el **Condroitín-sulfato (800-1200 mg/día)**. Han demostrado ser eficaces, principalmente en la artrosis de rodilla.
- El **Ácido Hialurónico** se administra por **vía intraarticular** (rodilla, cadera o primera carpometacarpiana) y es generalmente bien tolerado.

3. Tratamiento Quirúrgico

La cirugía de reemplazo protésico ofrece resultados satisfactorios para suprimir el dolor y permitir la movilidad articular. Las principales indicaciones para el recambio protésico son el **dolor refractario** y el **trastorno funcional grave** de la articulación. Se aconseja que el paciente sea **mayor de 65 años**. En un caso de artrosis secundaria de rodilla con ausencia del espacio articular en la Rx, la **cirugía de reemplazo protésico** es una recomendación.

Recuerda: La artrosis es un problema de **tuberías oxidadas** que se desgastan con el uso (dolor mecánico), a diferencia de la artritis, que es un problema de **tuberías que estallan** por alta presión (dolor inflamatorio continuo). La Rx te mostrará los **pinzamientos y los osteófitos**, que son el **"óxido y las calcificaciones"** propias del desgaste crónico.

🌟 FIBROMIALGIA (FM) 🌟

La Fibromialgia es un **padecimiento crónico, plurisintomático** y debilitante, de etiología desconocida, que se caracteriza por **dolor musculoesquelético crónico generalizado**. Es un trastorno que se ha asignado tradicionalmente a la reumatología, pero que se define como un **trastorno de sensibilización central**. Afecta predominantemente al **sexo femenino** (80%-90% de los casos).

💔 I. Clínica Típica: El Dolor que lo Caracteriza

El sello distintivo de la FM es su patrón de dolor, que se presenta en **ausencia de inflamación**.

📖 ¿Qué Tipo de Dolor Es? ¡El Dato Clave!

El dolor en la fibromialgia es un dolor **crónico generalizado**.

La característica semiológica más importante es la **disminución del umbral del dolor**. Esto se manifiesta clínicamente como:

- **Alodinia Generalizada:** Hipersensibilidad a la presión en diversas partes del cuerpo.
- El dolor es de tipo **difuso**.

📝 Otros Síntomas Definitorios (¡El Polimorfismo Clínico!)

El cuadro clínico es marcadamente multisintomático. Los síntomas cardinales y más frecuentes son:

Síntoma Clave	Frecuencia Aproximada
Fatiga Profunda (exhaustión abrumadora)	86% de los pacientes
Sueño No Reparador	65% de los pacientes
Trastornos del Estado de Ánimo (Ansiedad/Depresión)	62% de los pacientes
Parestesias	54% de los pacientes
Cefaleas	53% de los pacientes
Síndrome del Intestino Irritable (Colon Irritable)	44% de los pacientes

Importante: A diferencia de las artritis inflamatorias, en la fibromialgia **no hay sinovitis**, los arcos de movimiento son completos, y las pruebas de laboratorio (Hemograma, VSG, PCR, enzimas musculares) **no muestran alteraciones**.

II. Diagnóstico (Dx): Los Puntos Sensibles

El diagnóstico de la FM sigue basándose en gran medida en criterios clínicos y en la palpación de puntos específicos, aunque existen criterios más recientes basados en el índice de dolor generalizado y la gravedad de los síntomas.

Puntos Sensibles Gatillo (Criterios ACR 1990)

Los criterios de clasificación promulgados en 1990 siguen siendo válidos. El segundo criterio para el diagnóstico de FM requiere:

- La presencia de **dolor con la presión digital en 11 o más de los 18 puntos anatómicos específicos**.
- La palpación digital debe ejercerse con una fuerza aproximada de **4 kg**.
- Además, el dolor generalizado debe haber persistido por un mínimo de **3 meses**.

III. Tratamiento (Tto): el Enfoque Multimodal

El tratamiento de la FM requiere un enfoque terapéutico **multidisciplinario** que privilegie la educación y las medidas no medicamentosas. Se debe reafirmar la veracidad del dolor para construir una alianza terapéutica.

1. Medidas No Farmacológicas (¡Mandatorias!)

- El **ejercicio físico** y la **psicoterapia** (especialmente la terapia cognitivo-conductual) deben ser **mandatorios**. El ejercicio en el agua y el taichí han mostrado utilidad.
- Se debe buscar una mejoría a través de **cambios en el estilo de vida**.
- Evitar sustancias estimulantes como la nicotina o la cafeína.

2. Tratamiento Farmacológico (Resultados con Evidencia)

Los mejores resultados con terapia farmacológica se han observado con:

- **Antidepresivos Tricíclicos (ATC): Amitriptilina** (en dosis bajas, 12.5 a 50 mg en la noche) para mejorar el dolor y el insomnio.

- **Inhibidores de la recaptación de Serotonina y Noradrenalina (IRSN): Duloxetine y Milnacipran.**
- **Gabapentinoides: Pregabalina.**

🚫 Manejo del Dolor y Contraindicaciones

- **Dolor Agudo:** El dolor debe manejarse, en lo posible, con **Paracetamol**.
- **Opioides:** Los **opiáceos están contraindicados** para el tratamiento del dolor.
- **Tramadol:** Se debe reservar **solo para las reagudizaciones**.
- **AINes:** Generalmente, **no se deben usar AINes**.

En resumen: Tratar la Fibromialgia es como sintonizar un equipo de música con la sensibilidad al máximo 🎧. Necesitas **bajar el volumen central** (con fármacos como la Pregabalina o Amitriptilina) mientras **fortaleces los parlantes** (con ejercicio y psicoterapia) para que el ruido de fondo (dolor) no sature el sistema.

ARTRITIS PSORIÁSICA: LA CLAVE DE LAS ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS

I. Espondiloartropatías Seronegativas (EASN): Características Fundamentales

La Artritis Psoriásica (APs) es una enfermedad articular inflamatoria asociada a la psoriasis, caracterizada habitualmente por tener el **Factor Reumatoideo (FR) negativo**. Pertenecce al grupo de las Espondiloartropatías Seronegativas (EASN o EsP), que comparten rasgos clínicos y genéticos.

Rasgos Comunes Clave de las EASN:

1. **Factor Reumatoideo Negativo (Seronegativas):** Es una característica definitoria del grupo (FR-).
2. **Compromiso Articular Periférico:** Predominio **oligoarticular** (menos de 5 articulaciones) y **asimétrico**, que es sugestivo de EASN.
3. **Afectación Típica de Miembros Inferiores:** El compromiso periférico afecta principalmente las **extremidades inferiores**.
4. **Compromiso Axial:** Afectación del esqueleto axial, sobre todo **sacroilíaco** (sacroileítis), que en la APs puede ser unilateral o bilateral asimétrico.
5. **Entesitis: Inflamación del origen insercional de tendones, ligamentos o aponeurosis al hueso.** Es una manifestación clínica característica de las EsP. Los sitios más afectados son el tendón de **Aquiles** y la **fascia plantar**.
6. **Dactilitis:** Inflamación difusa de un dedo de la mano o pie, conocido como "**dedo en salchicha**". Es muy característico de las EsP, en especial de la APs.
7. **Asociación Genética:** Frecuente asociación con el antígeno **HLA-B27**. En APs, el HLA-B27 es positivo en aproximadamente el **25%**.

II. Articulaciones Afectadas y Diferencial con Artritis Reumatoidea (AR)

La APs es heterogénea y puede simular una AR, pero tiene características distintivas que evitan la confusión.

Patrones de Afectación Articular y Articulaciones Típicas

- **Oligoartritis Asimétrica:** Es la forma de presentación **más frecuente** (70% de los casos).
- **Afectación de IFD:** La artritis de **Interfalángicas Distales (IFD)** es una **característica distintiva** de la APs.
- **Articulaciones Comunes:** Puede comprometer pequeñas y grandes articulaciones. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son las **IFP y IFD**. El compromiso de la **Columna Cervical** es frecuente en la afectación axial.
- **Dactilitis:** El "**dedo en salchicha**" se presenta en el 40% de los pacientes al inicio, generalmente en los pies, afectando un máximo de 2 dedos.

Diferencias Clave con la Artritis Reumatoidea (AR)

La **Poliartritis simétrica** es una forma de presentación rara en la APs (< 5%), pero puede ser la forma de evolución más frecuente y se vuelve casi **indistinguible de la AR**.

Característica	Artritis Psoriásica (APs)	Artritis Reumatoidea (AR)
Patrón Típico	Oligoartritis asimétrica (70%).	Poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones.
Afectación Distal	Compromiso de IFD .	Generalmente preserva IFD .
Serología	Factor Reumatoideo negativo . Anti-CCP en baja frecuencia (5-16.7%).	FR positivo y/o Anti-CCP positivo.
Lesiones Típicas	Entesitis, Dactilitis , lesiones en " lápiz y copa " y proliferación ósea (periostitis).	Sinovitis, osteopenia yuxtaarticular , y erosiones marginales .

III. Manifestaciones Extraarticulares (MEA) y Complicaciones

La APs se asocia a múltiples comorbilidades (cardiovascular, obesidad, síndrome metabólico). Las MEA características son esenciales para el diagnóstico.

Manifestaciones Cutáneas y Ungueales (Muy Características)

- **Psoriasis Cutánea:** Generalmente precede al compromiso articular en un promedio de 10 años (70% de los pacientes). Se localiza en superficies de extensión (codos, rodillas) y sitios ocultos (cuero cabelludo, ombligo).
- **Compromiso Ungueal:** La afectación de las uñas se asocia en un alto porcentaje (50-80%) con compromiso articular.

- **Lesiones Típicas: Onicólisis** (separación de la uña), **lesiones punteadas** (*pitting*) e **hiperqueratosis**.
- Existe evidencia que apoya la **teoría uña-entesitis** (el compromiso ungueal se asocia a entesitis de los tendones extensores en las articulaciones interfalángicas distales).

Otras MEA

- **Compromiso Ocular:** La **uveítis anterior aguda** se presenta en el 20% de los pacientes. En la APs, la forma más frecuentemente reportada es la uveítis anterior, aguda y unilateral.
- **Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII):** La APs, como otras EsP, se puede asociar al compromiso inflamatorio del intestino (Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
- **Riesgo Cardiovascular (CV):** Los pacientes con APs tienen **mayor mortalidad** que la población general por **valvulopatías**.

IV. Criterios de Clasificación CASPAR (2006)

Los criterios **CASPAR** (Classification Of Psoriatic Arthritis) son los más utilizados en ensayos clínicos debido a su alta especificidad (98.7%) y sensibilidad (91.4%) para la APs establecida.

El paciente debe tener una **enfermedad articular inflamatoria** (articular, axial o entesal) y sumar **al menos 3 puntos** de los siguientes dominios:

Dominio	Criterios y Puntuación (Los más importantes)
Psoriasis	Evidencia de Psoriasis Actual (2 puntos) o Historia Personal de psoriasis (1 punto) o Historia Familiar (1 punto).
Compromiso Ungueal	Distrofia ungueal psoriásica típica (onicólisis, lesiones punteadas, hiperqueratosis).
Serología	Factor Reumatoideo (FR) negativo.
Dactilitis	Historia actual o pasada de dactilitis (inflamación total de un dedo).
Radiología	Evidencia radiográfica de neoformación ósea yuxta-articular (periostitis) en manos o pies.

V. Diagnóstico (Dx)

El diagnóstico es esencialmente **clínico**.

1. **Clínica:** Sospecha en todo paciente con psoriasis y artritis **seronegativa**. La presencia de **dactilitis** y **oligoartritis** es altamente indicativa de APs.

2. **Clasificación:** Uso de los criterios **CASPAR** (≥ 3 puntos).
3. **Laboratorio:** Los reactantes de fase aguda (PCR/VSG) **pueden estar elevados o ser normales**. Característicamente, **FR y Anti-CCP son negativos**.
4. **Imágenes (Radiología):** Útil para diferenciar de AR. Los hallazgos distintivos incluyen la **falta de osteopenia periarticular** (mineralización normal), **erosiones asociadas a cambios proliferativos** (periostitis, neoformación ósea) y la **asimetría**. El hallazgo de **osteólisis con lesiones tipo "lápiz y copa"** es típico de formas graves.

TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA:

RESUMEN ESENCIAL

1. Tratamiento Sintomático (Base)

Estos fármacos controlan el dolor y la inflamación mientras se espera el efecto de los DMARDs.

- **AINEs (Antiinflamatorios No Esteroideos):**
 - Son la **primera línea de tratamiento sintomático**.
 - Se sugieren para controlar los síntomas de la **artritis periférica activa**, el **compromiso axial** y la **entesitis**.
- **Corticoides (GC):**
 - **Orales/Sistémicos:** Su uso está **desaconsejado** (Débil en contra) ya que pueden **empeorar las lesiones cutáneas**.
 - **Infiltraciones Locales:** Se sugieren para la **artritis periférica activa**, **entesitis**, y **dactilitis**, dependiendo de la experiencia del reumatólogo y la disponibilidad de ultrasonografía.

2. DMARDs Convencionales (DMEc)

Son la primera opción para la afectación articular **periférica**, pero ineficaces para el componente axial.

Dominio Afectado	Fármacos de Elección (Fuerte a favor)	Indicación Clave
Artritis Periférica	Metotrexato (MTX) o Leflunomida.	Recomendados antes que ningún tratamiento (DMEc <i>naïve</i>).

Compromiso Axial (Columna, Sacroilíacas)	NO se recomienda el uso de DMEc (MTX, Leflunomida, Sulfasalazina).	Deben utilizarse terapias biológicas tras falla a AINEs.
--	---	--

3. Terapia Biológica y Dirigida (DMEb y FAMEsd) 🌟

Se utilizan cuando la enfermedad es refractaria o grave, o si el compromiso axial es significativo.

➤ Criterios para Indicar Terapia Biológica

1. **Falla a DMEc:** Cuando hay artritis periférica activa y **falla al tratamiento con DMEc** (generalmente Metotrexato).
2. **Falla Axial:** Cuando hay compromiso axial activo que **falla al tratamiento con 2 AINEs** usados a dosis óptimas durante **3 meses** (criterio extrapolado de Espondilitis Anquilosante).

4. Tratamiento No Farmacológico (Soporte) 🌱

La **fisioterapia** y el **ejercicio** son recomendados (Fuerte a favor) para pacientes con artritis periférica activa y/o compromiso axial, y deben acompañar al tratamiento farmacológico.

Analogía Final: La Artritis Psoriásica es como un **artista que pinta sobre un hueso ya dañado** 🎨. A diferencia de la AR (que solo excava cuevas, dejando el hueso débil y desmineralizado), la APs no solo erosiona el hueso (erosiones), sino que también **intenta repararlo de forma desordenada** (neoformación ósea, periostitis), dando lugar a la clásica imagen **asimétrica y proliferativa** en la radiografía.

👑 ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA): LA ENFERMEDAD DEL EJE AXIAL 👑

La EA es la principal enfermedad inflamatoria crónica que afecta al **esqueleto axial** (columna vertebral y sacroilíacas) y a las **entesis**. Se caracteriza por una pérdida acelerada y progresiva de la movilidad de la columna. Afecta predominantemente a **hombres** (M:F 2-3:1) y comienza típicamente entre los **20 y 40 años**.

I. Características Compartidas: El Grupo EASN 🛡️

La EA pertenece al grupo de las Espondiloartropatías Seronegativas (EASN) que comparten rasgos clínicos y genéticos.

🧬 Asociación Genética

El antígeno **HLA-B27** es positivo en el **90-95%** de los pacientes con EA. Sin embargo, la presencia de este antígeno **no es sinónimo** de EA, ya que solo el 5% de las personas B27+ desarrollan la enfermedad.

📝 Rasgos Clave de las EASN:

- **Factor Reumatoideo Negativo (Seronegativas):** Característica definitoria.
- **Compromiso Axial:** Afectación del esqueleto axial, sobre todo **sacroilíaco**.
- **Compromiso Periférico:** Patrón de afección **oligoarticular asimétrico**, principalmente en **miembros inferiores**.
- **Entesitis y Dactilitis:** La **Entesitis** (inflamación de la inserción de tendones y ligamentos al hueso) es una manifestación cardinal de las EsP, afectando principalmente el **Aquiles** y la **fascia plantar**.

II. Clínica Cardinal: El Dolor Inflamatorio 🔥

El sello de la EA es la naturaleza inflamatoria del dolor axial, que progresa hasta la **anquilosis**.

🤔 Dolor Lumbar Inflamatorio (El Sello)

El dolor lumbar en la EA posee características distintivas:

- **Comienzo:** En la adolescencia o adulto joven, de forma insidiosa.
- **Localización:** Lumbar bajo, glúteo o caderas, frecuentemente **alternante**.
- **Ritmo:** **Empeora con el reposo y mejora con el ejercicio.**
- **Rigidez Matutina:** Intensa y prolongada.
- **Respuesta a AINEs:** Excelente respuesta a los AINEs.

Afectación Articular y Examen Físico

1. **Afectación Axial:** La **sacroileítis** ocurre en el **100%** de los pacientes con EA y es típicamente **simétrica**. La limitación progresiva de la movilidad lumbar y la disminución de la expansión torácica son hallazgos clave.
2. **Afectación Periférica:** El 50% de los pacientes compromete **hombros o caderas**. La artritis periférica es **oligoarticular y asimétrica**, afectando principalmente **miembros inferiores**. La artritis de cadera es la más frecuente y grave de las afectaciones periféricas.
3. **Entesitis:** Es una manifestación frecuente, principalmente en el **Aquiles** y la **fascia plantar**.

III. Diagnóstico: Criterios y Hallazgos Radiológicos

El diagnóstico se basa en la clínica y la demostración de sacroileítis.

Criterios de Clasificación (NY Modificados 1984)

Se clasifica a un paciente con EA si tiene **un criterio clínico y un criterio radiológico**:

Criterios Clínicos (Debe tener al menos uno)	Criterios Radiológicos (Debe tener al menos uno)
Dolor lumbar > 3 meses que mejora con el ejercicio.	Sacroileítis bilateral de grado ≥ 2.
Limitación a la movilidad lumbar.	Sacroileítis unilateral de grado 3 o 4.
Expansión torácica disminuida.	

Hallazgos Radiológicos Típicos

La radiografía convencional es la base para el diagnóstico de la enfermedad establecida, pero los cambios tardan semanas o años en aparecer.

- **Columna Vertebral:**
 - **Signo de Romanus:** Erosiones en las esquinas vertebrales.

- **Cuadratura Vertebral** (*Squaring*): Pérdida de la concavidad anterior de los cuerpos vertebrales.
- **Sindesmofitos**: Prolongaciones óseas verticales que se unen a las vértebras adyacentes, dando la imagen de "**columna en caña de bambú**".
- **Entesitis Radiológica**: Erosiones u **osificaciones** en las inserciones tendinosas y ligamentarias, como entesofitos plantares y calcificación de la entesis aquiliana.
- **Detección Precoz**: La **Resonancia Magnética (RM)**, especialmente la secuencia STIR, es la prueba de elección para el **diagnóstico precoz**, ya que detecta la **inflamación activa (edema óseo)** en las articulaciones sacroilíacas mucho antes que la Rx.

IV. Manifestaciones Extraesqueléticas y Complicaciones ⚠

Las MEA son frecuentes y pueden ocurrir al inicio o durante los brotes.

Sistema	Manifestación Específica	Tipo de Daño	Relevancia
Ocular	Uveítis Anterior Aguda (Iritis/Iridociclitis).	Inflamación unilateral, autolimitada y recurrente.	Ocurre en cerca del 40% de los casos, frecuentemente con HLA-B27 positivo.
Óseo	Osteoporosis Acelerada y Fracturas Espinales.	Osteoporosis relacionada con la actividad axial.	Las fracturas espinales (15-20%) son un riesgo importante.
Cardíaco	Insuficiencia Valvular Aórtica, Bloqueos Cardíacos.	Inflamación de la raíz aórtica.	
Pulmonar	Fibrosis de los lóbulos pulmonares superiores.	Restricción pulmonar debido a la disminución de la movilidad de la caja torácica.	
Neurológico	Subluxación atlantoaxoidea (2%).	Puede causar mielopatía grave.	
Asociaciones	Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y Psoriasis.		La EII (Crohn o Colitis Ulcerosa) ocurre en 10-20% de los pacientes.



✓ Criterios de Mal Pronóstico

Los factores de peor pronóstico para la progresión y limitación funcional son:

- Afectación precoz de la **cadera**.
- Elevación **persistente de la PCR**.
- Limitación precoz de la movilidad lumbar.
- Presencia de oligoartritis y edad de comienzo **antes de los 16 años**.

V. Tratamiento Estratégico

El objetivo principal es maximizar la calidad de vida a través del control de los síntomas, la prevención del daño estructural y la preservación de la función.

1. No Farmacológico (Base Obligatoria)

La **fisioterapia**, la educación sanitaria y el ejercicio son obligatorios en cualquier pauta de tratamiento.

2. Tratamiento Farmacológico Inicial: AINEs (Primera Línea)

- **AINEs:** Son la **primera línea de tratamiento farmacológico**. Deben usarse a **dosis plenas** y, si la enfermedad es persistentemente activa, se prefiere el **tratamiento continuo** con AINEs.
 - Existe un aparente beneficio de los COX-2 selectivos sobre los no selectivos.
- **Corticoides:** Generalmente, los corticoides sistémicos **no están indicados en la EA axial**. Solo se usan para **infiltración local** en casos de afectación mono- o pauciarticular periférica o **entesopatía refractaria**.
- **DMARDs Convencionales (Sulfasalazina, MTX):**
 - **Compromiso Axial:** Los DMARDs tradicionales (como Metotrexato y Leflunomida) están **discutidos en el compromiso axial**.
 - **Compromiso Periférico:** La **Sulfasalazina** (2-3 g/día) puede ser eficaz en pacientes que no responden a AINEs y presentan **artritis periférica**. El Metotrexato puede utilizarse en el compromiso periférico.

3. Terapia Biológica (Indicaciones Estrictas)

La terapia biológica se utiliza en casos resistentes a AINEs y ha demostrado ser el avance principal en el tratamiento.

Clase de Fármaco	Indicación Clave	Fármacos Ejemplos
Anti-TNF α	Falla al tratamiento con 2 AINEs diferentes usados a dosis óptimas por 3 meses .	Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab.
Anti-IL-17	Alternativa a los Anti-TNF α en pacientes resistentes a AINEs.	Secukinumab.

Criterio de Introducción de Biológico: Falla a 2 AINEs durante 3 meses con un índice de actividad elevado (BASDAI > 4).

*El tratamiento de la EA es como la lucha por mantener la flexibilidad de una torre que tiende a osificarse. Los **AINEs** son el aceite que permite que las partes se muevan hoy, mientras que los **Biológicos** son la ingeniería avanzada que detiene la fusión de los ladrillos (vértebras) a largo plazo, preservando la movilidad. 🏗️🔧*

ARTRITIS SÉPTICA: UNA URGENCIA REUMATOLÓGICA

I. Concepto y Etiología: La Invasión Articular

La **Artritis Séptica** se utiliza a menudo como sinónimo de artritis infecciosa y se refiere al proceso inflamatorio originado por la **colonización de la articulación por un microorganismo**. Constituye una **urgencia médica** debido a su alta capacidad de **destrucción articular acentuada** y el riesgo vital que conlleva para el paciente.

Causas y Vías de Infección

La vía de infección más común es la **hematógena**. La membrana sinovial está muy vascularizada y no tiene una membrana basal limitante, lo que favorece la colonización en caso de bacteriemia.

Factores de Riesgo (Predisponentes)

La coexistencia de factores generales o locales es un hallazgo frecuente:

- **Enfermedad Crónica/Inmunodepresión:** **Diabetes mellitus**, neoplasia, cirrosis hepática, insuficiencia renal, alcoholismo.
- **Uso de Drogas:** **Adicción a drogas por vía parenteral (UDVP)**.
- **Artropatía Previa:** La existencia de una artropatía crónica de base (ej., Artritis Reumatoidea) o una **prótesis articular** facilita la aparición de AS.
- **Procedimientos:** Infecciones que siguen a procedimientos de **artrocentesis** o lesión traumática.

Microorganismos Frecuentes

Grupo de Pacientes	Microorganismo Más Común (Causa Principal)	Otras Consideraciones
Global/Adultos	Staphylococcus aureus (50% al 60% de los casos).	<i>S. aureus</i> es el principal agente etiológico de bursitis, AS y osteomielitis.
SARM	Cepas resistentes a la meticilina (<i>S. aureus</i> resistente a la meticilina).	Más común en infección nosocomial o pacientes institucionalizados.

UDVP	S. aureus (predominio notable).	Frecuente afectación de articulaciones axiales (sacroilíacas, esternoclaviculares).
Niños (1-4 años)	<i>Haemophilus influenzae</i> y Kingella kingae .	<i>K. kingae</i> es la causa más frecuente de artritis en niños menores de 3 años.
Ancianos/Debilitados	Bacilos Gram negativos , enterobacterias, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	
Jóvenes/Actividad Sexual	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (artritis gonocócica).	Forma especial; en fase de bacteriemia, poliartralgias/tenosinovitis; luego monoartritis.

II. Clínica Típica y Patrón de Afectación

Manifestación Clave

La AS suele ser **monoarticular**.

- **Articulaciones Afectadas:** Predilección por **grandes articulaciones** de las extremidades inferiores (principalmente **rodilla y cadera**) y superiores (**hombro, muñeca**).
- **Presentación:** Generalmente de forma **aguda**, con **fiebre** más o menos elevada, **dolor de características inflamatorias e impotencia funcional**.
- **Signos Inflamatorios:** En las articulaciones superficiales (ej., rodilla), los signos inflamatorios suelen ser evidentes, con **tumefacción** y **eritema periarticular** en cerca del **50% de los casos**.

Artritis Séptica vs. Inflamatoria/Cristalina

El dolor inflamatorio persiste en reposo, mientras que el dolor mecánico (Artrosis) cede con el reposo. La presencia de **eritema periarticular** debe sugerir la existencia de una **artritis infecciosa**. No obstante, la ausencia de fiebre no descarta sistemáticamente una artritis infecciosa, ya que en cerca del **30% de los casos predominan los síntomas locales** con febrícula o apirexia.

III. Diagnóstico (Dx)

El diagnóstico de la artritis infecciosa se basa principalmente en la clínica y el **estudio del líquido sinovial (LS)**. Es una buena práctica clínica **cultivar el material obtenido en una artrocentesis**.

Análisis del Líquido Sinovial (LS)

1. **Aspecto Macroscópico:** Típicamente **turbio o francamente purulento**.
2. **Recuento Celular (Criterio de Infección):** Usualmente superior a **50.000/μL**. En casos de artritis por pirofosfato cálcico, la celularidad también puede superar los 50.000/μL, lo que hace **obligatorio el cultivo** del líquido sinovial.
3. **Diferencial Leucocitario:** Porcentaje de **polinucleares superior al 75%**.
4. **Microbiología:**
 - **Tinción de Gram:** Positiva en el **75% de las AS por Gram positivos** y en el **50% de las Gram negativas**.
 - **Cultivo:** La rentabilidad es alta: **80% a 85%** en artritis sépticas no gonocócicas.
5. **Diferencial:** Es fundamental determinar de forma sistemática la presencia de **microcristales** (gota o pirofosfato cálcico), ya que las artropatías microcristalinas son el principal diagnóstico diferencial y pueden coexistir con la AS.

Reactantes de Fase Aguda (RFA)

- **Elevación:** Los episodios de artritis infecciosa aguda se asocian a una **reacción de fase aguda**. La **VSG y/o PCR** (Proteína C Reactiva) suelen estar **elevadas**.
- **Valor de PCR:** La PCR es un reactante útil. Los niveles de PCR **aumentan rápidamente** en los procesos infecciosos agudos y su monitorización es útil para valorar la respuesta al tratamiento.
- **Hematología:** Es común la **leucocitosis con neutrofilia**.

Hallazgos en Rx y RMN

- **Radiografía Simple (Rx):** En las fases iniciales, la Rx puede ser **normal** o mostrar signos inespecíficos como **tumefacción de partes blandas** y **osteopenia periarticular**. La disminución de la interlínea articular junto con destrucción ósea sugiere artritis infecciosa. A partir de la tercera semana, se observa una **disminución del espacio articular** y posteriormente, **lesiones erosivas**.
- **Resonancia Magnética (RMN):** La RMN es la prueba más sensible y específica para delimitar la **extensión y localización de la infección**. Es de particular interés en localizaciones próximas al esqueleto axial. Permite diferenciar la infección osteoarticular de otros procesos, especialmente en pacientes con pie diabético.

IV. Tratamiento (Tto)

El tratamiento de la AS es una **urgencia** y debe iniciarse lo antes posible en el área de urgencias.

1. **Drenaje Articular (Capital):** El drenaje de la articulación es de **importancia capital**. La artrocentesis evacuadora repetida no suele ser suficiente, por lo que a menudo debe recurrirse al **desbridamiento quirúrgico**.
2. **Antibioticoterapia:** Debe ser **adecuada** e iniciarse por vía intravenosa, preferiblemente guiada por la tinción de Gram.
 - **Empírica:** El esquema empírico debe cubrir a **Staphylococcus aureus** y estreptococos.
 - Para **Estafilococos sensibles a meticilina (SASM): Cloxacilina o Cefazolina.**
 - Para **SARM o alérgicos a penicilina: Vancomicina o Ceftarolina.**
 - **Duración:** Varía según el microorganismo y factores del huésped. Se recomienda un mínimo de **4 semanas** para artritis por *S. aureus* y **6 semanas** para bacilos Gram negativos.
3. **Inmovilización:** La articulación debe **inmovilizarse en posición funcional**. Posteriormente, se inicia fisioterapia de forma precoz.

ARTRITIS REACTIVA (AR_e): LA INFLAMACIÓN POST-INFECCIOSA

La Artritis Reactiva es una enfermedad que se caracteriza por una **inflamación articular aséptica** que aparece tras un proceso infeccioso en un sitio distante, generalmente intestinal o urogenital. La ARE pertenece al grupo de las **Espondiloartropatías Seronegativas (EASN)**.

I. Etiología y Microorganismos Causales

La ARE se desencadena por la infección, que ocurre en individuos **genéticamente susceptibles**. El patrón de inicio se presenta típicamente entre **1 y 4 semanas** después de la infección desencadenante.

Patógenos Reconocidos (Causas)

Un panel de expertos determinó una lista específica de patógenos gastrointestinales y urogenitales considerados causales.

Origen	Patógenos Causales Más Frecuentes
Urogenital	<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> .
Gastrointestinal	<i>Yersinia</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> y <i>Campylobacter</i> . También se han agregado <i>Escherichia coli</i> y <i>Clostridium difficile</i> .
Otros	Infección por Estreptococco del grupo A y <i>Chlamydia pneumoniae</i> .

- **Nota Epidemiológica:** La ARE asociada a infección **urogenital** es más frecuente en **varones**.

II. Clínica Típica: Articular y Extraarticular

Afectación Articular (Clínica)

La ARE se presenta con un patrón típico de afectación articular.

- **Patrón:** Típicamente es **monoarticular u oligoarticular** (inflamación de 2 a 4 articulaciones). Puede clasificarse como poliartritis en ciertos contextos.
- **Distribución:** Es **asimétrica**.

- **Articulaciones:** Afecta a **grandes articulaciones**, principalmente de las **extremidades inferiores** (rodilla, tobillo o metatarsofalángicas - MTFs). El compromiso de miembros superiores es **excepcional**.
- **Evolución Crónica:** Cuando se cronifica (más de 6 meses), la artritis puede llegar a ser muy **incapacitante, erosiva y con proliferación ósea**.

Manifestaciones Extraarticulares Frecuentes

La ARe se conocía clásicamente por la tríada de **artritis, conjuntivitis y uretritis**. Las manifestaciones extraarticulares suelen ser leves y pueden ocurrir al inicio o durante los brotes.

Dominio	Manifestaciones Clave	Detalle y Relevancia
Genitourinario	Uretritis, Balanitis Circinada , Cervicitis, Prostatitis.	La uretritis puede ser una manifestación de la infección original o un síntoma reactivo aséptico.
Ocular	Conjuntivitis, Uveítis Anterior Aguda.	La conjuntivitis es la manifestación ocular más común. La uveítis anterior aguda ocurre en el 5% de los pacientes, es aguda, anterior y generalmente unilateral.
Musculoesquelético	Entesitis y Dactilitis.	La entesitis se observa hasta en el 70% de los pacientes, afectando las inserciones calcáneas (Aquiles y fascia plantar). La dactilitis ("dedo en salchicha") se observa en el 15%.
Cutáneo	Queratoderma Blenorragico y lesiones psoriasiformes.	La Queratoderma Blenorragico (lesiones pustulares) es una manifestación dermatológica frecuente. También puede presentarse Eritema nudoso .
Axial	Sacroileítis asimétrica.	Ocurre con mayor frecuencia cuando la ARe se convierte en una enfermedad crónica. Cuando afecta al esqueleto axial, puede ser similar a una espondilitis anquilosante clásica.
Constitucionales	Fiebre alta, astenia, malestar general, o pérdida de peso (usualmente leves).	

III. Diagnóstico (Dx)

El diagnóstico se basa en las características clínicas de la artritis y en la evidencia de una infección desencadenante previa.

Laboratorio y Reactantes de Fase Aguda

- **Reactantes de Fase Aguda (RFA):** La **Velocidad de Eritrosedimentación (VES)** y la **Proteína C Reactiva (PCR)** suelen estar **aumentadas o elevadas** en la etapa aguda de la enfermedad.
- **Serología:** Los anticuerpos **Factor Reumatoideo (FR)** y **Anti CCP** son **negativos**.
- **Genético:** El **HLA-B27** es positivo en el 50%-80% de los pacientes con ARe.
- **Líquido Sinovial (LS):** El recuento de leucocitos se sitúa entre **2.000 y 64.000/mm³**. El aspecto es inflamatorio y, por definición, el **cultivo es negativo** (artritis estéril).



Hallazgos en Rx o RMN

- **Radiografía Simple (Rx):** En fases iniciales, solo se observa **tumefacción de partes blandas**. Posteriormente, tras episodios repetidos de artritis, se puede observar **proliferación ósea reactiva asimétrica, reacción perióstica y erosiones** en las zonas de entesitis (ej., tendón de Aquiles). Los hallazgos radiográficos de la ARe son **similares a los de la Artritis Psoriásica (APs)**.
- **Resonancia Magnética (RMN):** Se utiliza para identificar anomalías de la membrana sinovial, el cartílago, el tendón, la entesis y las sacroilíacas.

IV. Tratamiento (Tto)

El pronóstico es generalmente bueno, con **remisión espontánea** en la mayoría de los pacientes dentro de los **6 a 12 meses**.

1. Tratamiento Agudo (Síntomas)

1. **AINes:** Son la **piedra angular del tratamiento**. Deben emplearse lo más tempranamente posible, de forma regular y en dosis altas, ya que controlan el dolor y la inflamación.
2. **Corticoides:** Se pueden utilizar **sistémicos** a dosis medias o bajas (ej. 10–20 mg/día de prednisona por 2 a 4 meses) para casos de poliartritis, o mediante **infiltraciones intraarticulares** para complementar el tratamiento.

2. Tratamiento de la Infección Desencadenante

- Se recomienda la **búsqueda del agente causal**. Si se identifica la infección activa (ej. *Chlamydia trachomatis*) se recomienda realizar **tratamiento antibiótico**.
- Los antibióticos recomendados incluyen **azitromicina, doxiciclina, rifampicina y ciprofloxacino**.

3. Tratamiento Crónico o Refractario

El uso de Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad (DMARDs) solo está justificado en pacientes que **no responden a AINEs** (20%-25% de los casos) durante los primeros **3 meses**.

- **DMARDs Convencionales:**
 - Fármaco de elección: **Sulfasalazina** (1 a 3 g/día).
 - Alternativas: **Metotrexato** (10 a 25 mg/semana, suplementado con ácido fólico) o Azatioprina.
- **Falla a DMARDs:** Se debe considerar el inicio de **Terapia Biológica (Anti-TNF α)**, como Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Golimumab o Certolizumab.

💎 GOTA: LA ENFERMEDAD DEL CRISTAL DE URATO 👑

La Gota se caracteriza por el **depósito de cristales de urato monosódico (UMS)**, principalmente en estructuras articulares y periarticulares, debido a concentraciones elevadas de ácido úrico en el suero (**hiperuricemia**). Es una de las **artritis microcristalinas**. La enfermedad es considerada **curable**, ya que la normalización de la uricemia provoca la disolución de los cristales.

I. Clínica Típica y Articulaciones Afectadas ⚡

La gota se manifiesta clínicamente por episodios de **artritis aguda**.

🤒 Características del Ataque Agudo (Crisis)

- **Comienzo: Abrupto**, frecuentemente **nocturno**.
- **Dolor e Inflamación:** El dolor es **intenso**, con **eritema local** (que puede simular una celulitis, especialmente en tarso) y **tumefacción**.
- **Resolución:** Revierte espontáneamente entre **3 a 10 días**.
- **Síntomas Generales:** Si el ataque es intenso o poliarticular, puede cursar con **fiebre** y **leucocitosis**, simulando un proceso infeccioso.

📌 Articulaciones Afectadas (Podagra)

La Gota suele ser **monoarticular**.

- **Primera Articulación:** El **75% de los casos** debutan en la **primera articulación metatarsofalángica (1ª MTF)** del dedo gordo del pie, lo que se conoce como **Podagra**.
- **Otras Localizaciones Frecuentes:** Tarso, **tobillo**, **rodilla**, muñeca, articulaciones metacarpofalángicas (MCF), interfalángicas (IF) de la mano, y la **bursa olecraneana** (**pequeña bolsa sinovial ubicada en la parte posterior del codo, entre el olécranon (extremo proximal del cúbito) y la piel.**).
- **Gota Tofácea:** En la enfermedad de evolución prolongada aparecen los **tofós** (nódulos palpables de cristales de urato). Se localizan en la superficie de extensión de los **codos**, articulaciones de manos, pies o rodillas, **pabellón auricular** (hélix y antehélix), y tendón aquileo.

II. Factores de Riesgo (FR) 🍺

La gota es consecuencia de la hiperuricemia, y la hiperuricemia por sí sola requiere de **10 a 12 años** para que se desarrolle la gota.

- **Genéticos/Demográficos:** Más frecuente en el **varón** que en la mujer premenopáusica (15:1). Las mujeres suelen padecerla tras la **menopausia**.
- **Dietéticos/Hábitos Tóxicos:** **Consumo de alcohol** (que eleva la uricemia y reduce la excreción renal de ácido úrico), **excesos alimenticios** (dieta alta en purinas), y **ayuno prolongado**.
- **Farmacológicos (Drogas):** Uso de **diuréticos**, o **aspirina a bajas dosis**.
- **Otros Factores Precipitantes:** Trauma, **descenso brusco de la uricemia** (al iniciar el tratamiento hipouricemiante), e intervenciones quirúrgicas.

III. Líquido Sinovial (LS) y Microscopía 🔬

El estudio del líquido sinovial es la forma más rápida y simple de obtener un **diagnóstico inequívoco**.

🌿 Características del LS Patológico (Inflamatorio)

- **Aspecto:** Amarillo turbio o en **lechada de cal**.
- **Celularidad:** LS es de naturaleza **inflamatoria**. El recuento de glóbulos blancos (GB) es **> 5.000/μL** (LS tipo II).
- **Cultivo:** Se debe **siempre cultivar el líquido sinovial** para descartar una artritis séptica, dado que la celularidad puede ser similar.

🔍 Cristales de Urato Monosódico (UMS)

- **Forma:** **Aguja o bastón**.
- **Tamaño:** 5-25 μm.
- **Birrefringencia con Luz Polarizada:** **Intensa** y de **elongación negativa**.
- **Localización:** Se encuentran en el LS, a menudo **intraleucocitarios**.

IV. Diagnóstico (Dx): Crisis vs. Intercrisis ⚖️

El diagnóstico de certeza se establece mediante la **identificación de cristales de UMS** en el LS.

Dx en Crisis Aguda

En la fase activa, el diagnóstico se establece mediante la **demostración de cristales de urato monosódico en los leucocitos del LS**.

- **Hiperuricemia:** Puede haber hiperuricemia o no, por lo que **no sirve para el diagnóstico del ataque agudo de gota**.
- **Laboratorio:** Leucocitosis y aumento de VSG/PCR.
- **Radiología:** En la crisis aguda, la Rx solo muestra **tumefacción de partes blandas**.

Dx en Período Intercrítico

El paciente está **totalmente libre de síntomas**.

- Se puede buscar el diagnóstico encontrando cristales en el LS de articulaciones previamente inflamadas.
- El diagnóstico también se establece mediante la demostración de cristales de UMS en un **tofo biopsiado o aspirado**.

V. Diferencia entre Gota y Pseudogota (PFCa)

Característica	Gota (Cristales de Urato Monosódico - UMS)	Pseudogota (Cristales de Pirofosfato de Calcio - PFCa)
Cristal Causante	Urato monosódico.	Pirofosfato de Calcio Dihidratado.
Afectación Típica	1ª MTF (Podagra) (75% de los casos).	Rodilla , carpos, hombros, tobillos, codos.
Birrefringencia	Intensa . Elongación negativa .	Débil . Elongación positiva .
Morfología	Aguja o bastón .	Pleomórficos (bastón, romboidal, polimorfo).
Hallazgo Radiológico	Erosiones yuxtaarticulares con borde esclerótico, no hay osteopenia .	Condrocálcinosis (calcificación del cartílago hialino, meniscos, etc.).
Cura	Curable (por disolución de los cristales).	No existen drogas para remover cristales .

VI. Tratamiento (Tto): La Diferencia Esencial

El tratamiento debe ser **diferente** en la crisis aguda e intercrisis porque la administración de fármacos que disminuyen bruscamente la uricemia (como el Alopurinol) durante la fase activa puede **precipitar o exacerbar un ataque de gota**.

● Tto en Crisis Aguda (Detener la Inflamación)

El objetivo es aliviar la inflamación.

- **Fármacos:** AINEs, Colchicina o Corticoides (oral, parenteral o intraarticular).
- **Regla de Oro:** NO DAR ALLOPURINOL ni otros hipouricemiantes EN LA FASE ACTIVA.

● Tto Intercrítico (Eliminar Cristales y Prevenir)

El objetivo es controlar la hiperuricemia y lograr la disolución de los cristales.

1. **Profilaxis de Ataques:** La Colchicina (0.5–1 mg/día) debe administrarse durante las fases intercríticas, ya que disminuye la inflamación subclínica y previene nuevos ataques. La profilaxis debe mantenerse al menos **varios meses** tras el inicio del tratamiento hipouricemiante.
2. **Control de Hiperuricemia (Hipouricemiantes):**
 - **Inhibidores de la Xantino-Oxidasa:** Allopurinol (se debe ajustar a la función renal) o Febuxostat.
 - **Uricosúricos:** Probenecid, Sulfinpirazona, Benzobromarona.
3. **Objetivo Terapéutico:** Mantener la uricemia por **debajo de 6 mg/dL**.

Analogía Final: La Gota es como un **terremoto** (la crisis aguda) causado por la acumulación subterránea de **piedras puntiagudas** (cristales de urato).

- Durante el terremoto (Crisis), solo se pueden usar **calmantes** (AINEs/Colchicina) para que la gente no sufra.
- Una vez que el temblor pasa (Intercrisis), se usan las **máquinas excavadoras** (Alopurinol) para **retirar las piedras acumuladas**, y se sigue dando un **calmante preventivo** (Colchicina) para evitar que la excavación desencadene nuevos derrumbes.


MIOPATÍAS INFLAMATORIAS: DEL DOLOR A LA DEBILIDAD

I. Polimialgia Reumática (PMR): La Debilidad del Adulto Mayor

La PMR es una entidad clínica que tradicionalmente se incluye en el diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias, pero que tiene características clínicas y de laboratorio muy definidas.

Clínica Típica de la PMR (¡El Caso Clínico Frecuente!)

La PMR es una enfermedad propia del paciente de edad avanzada, afectando al **95% de los casos a mayores de 60 años**.

- **Dolor y Debilidad Proximal:** Se caracteriza por **dolor** y **rigidez** (no debilidad en el sentido miopático puro). El inicio es **súbito**.
- **Localización:** Afecta a las **cinturas**, principalmente la **cintura escapular** (hombros) y, menos frecuente, la **cintura pelviana** (caderas) y **cuello**.
- **Movilidad:** Causa una **limitación en el rango de movimiento activo** de los hombros, el cuello y las caderas.
- **Rigidez:** La rigidez matutina es notable.
- **Inflamación Asociada:** Puede acompañarse de **sinovitis distal**, afectando especialmente a las **muñecas** y las articulaciones **metacarpofalángicas (MCF)**.
- **Laboratorio:** Se asocia a **anemia** y **VSG elevada**. El **Factor Reumatoide (FR)** y los **Anti CCP** son **negativos**.
- **Tratamiento:** Típicamente, **remite con bajas dosis de corticoides** (10 a 20 mg) en aproximadamente 18 meses.

II. Diagnóstico General de las Miopatías Inflamatorias

Las Miopatías Inflamatorias Idiopáticas (MII) incluyen la Dermatomiositis (DM), la Polimiositis (PM), la Miopatía Necrotizante Inmunomediada (MNIM) y la Miositis con Cuerpos de Inclusión (MCI).

Estudios Necesarios para el Diagnóstico

El diagnóstico de miopatía inflamatoria requiere la exclusión de otras causas (como las miopatías endócrinas, inducidas por fármacos o las distrofias).

Paso Diagnóstico	Hallazgo Típico en Miopatía
Clínica	Debilidad muscular proximal simétrica (cintura pélvica/escapular), generalmente no dolorosa e insidiosa .
Enzimas Musculares	CPK elevada (mayor sensibilidad), TGO, LDH, ALDOLASA. La CK puede ser normal en enfermedad activa.
Electromiograma (EMG)	Patrón miopático puro (potenciales polifásicos de corta duración y baja amplitud). Es positivo en el 90% y ayuda a determinar el mejor sitio para la biopsia .
Autoanticuerpos	ANA (+) en 80-90%. Específicos: Anti-Mi2, Anti-SRP, Antisintetasas (Jo-1, PL7, PL12).
Resonancia Magnética (RM)	Ayuda a identificar la participación de grupos musculares y la selección del músculo a biopsiar . Muestra edema muscular (actividad inflamatoria) y reemplazo fibroadiposo (cronicidad).
Biopsia Muscular	Es esencial para el diagnóstico. Debe mostrar necrosis y fenómenos inflamatorios .

III. Fenómeno de Raynaud Asimétrico: Sospecha y Estudios

El Fenómeno de Raynaud (FR) consiste en una vasoconstricción paroxística. Cuando es **asimétrico** o afecta a un solo dedo (o al pulgar), se considera **secundario u orgánico**.

Enfermedad Sospechada

En un Raynaud asimétrico, la sospecha principal es una **enfermedad autoinmune sistémica o conectivopatía**. La **Esclerodermia (Esclerosis Sistémica)** es la causa subyacente más común de Raynaud secundario.

Estudios Clave

El diagnóstico del Raynaud secundario requiere una investigación exhaustiva:

1. **Capilaroscopia del Lecho Ungueal:** Es el estudio fundamental. Permite diferenciar el Raynaud primario (normal) del secundario. Los hallazgos típicos de esclerodermia

incluyen **dilataciones capilares (megacapilares)**, **hemorragias** y **áreas con ausencia de capilares**.

2. **Autoanticuerpos:** Para buscar la enfermedad de base (LES, Esclerodermia, etc.). Se solicitan **ANA** y anticuerpos específicos (**Anti-Scl 70**, **Anticentrómero**, **Anti-RNP**).
3. **Reactantes de Fase Aguda:** Se solicitan **VSG** y **PCR**.

IV. Dermatomiositis (DM) vs. Polimiositis (PM): Criterios y Diferencias

La PM y la DM son dos de las miopatías inflamatorias idiopáticas más importantes.

1. Criterios de Clasificación (Bohan y Peter, 1975)

Ambos diagnósticos se basan en una combinación de 5 criterios:

1. **Debilidad muscular proximal simétrica.**
 2. **Evidencia de miositis en la biopsia muscular.**
 3. **Enzimas musculares elevadas.**
 4. **Patrón electromiográfico característico.**
 5. **Rash cutáneo característico** (solo para DM).
- **DM Definida:** Criterio 5 (Rash cutáneo) + otros 3 criterios.
 - **PM Definida:** Criterios 1 al 4. La PM es un **diagnóstico de exclusión** que agrupa diversos trastornos y cuya existencia como entidad nosológica aislada ha sido relativizada.

2. Diferencias Clínicas y Serológicas Clave

Característica	Dermatomiositis (DM)	Polimiositis (PM)
Manifestación Cutánea	Siempre presente (criterio 5). Pápulas de Gottron (papuloeritematosas en dorso de MCF e IFP/IFD). Eritema en Heliotropo (edema violáceo periorbitario).	Ausente.
Neoplasia Asociada	Frecuente asociación paraneoplásica (hasta el 25% en adultos).	Menor asociación que la DM.
Anticuerpos Típicos	Anti-Mi2 (forma clásica). Anti-MDA5 (asociado a enfermedad pulmonar grave y DM amiopática). Anti-TIF1γ (asociado a neoplasia).	Anti-SRP, Anti-HMGCR (estatinas), Antisintetasas (Jo-1).

3. Diferencias Histológicas (Biopsia)

Aunque en ambas hay necrosis e inflamación:

- **DM:** El daño se produce por **isquemia microangiopática (vasculitis)**. Hay atrofia **perifascicular** e infiltración **perivascular** mayoritariamente de Linfocitos B.
- **PM:** El daño se produce por infiltración de **Linfocitos T CD8+ citotóxicos** a nivel **endomisional** (dentro de los fascículos).



V. Tratamiento de las Miopatías Inflamatorias (DM/PM)

El tratamiento tiene tres pilares fundamentales: agentes inmunomoduladores/inmunosupresores, erradicación de factores causales y **terapia física** (rehabilitación precoz).

1. Inmunosupresión (Fármacos de Elección)

El tratamiento de elección son los **Glucocorticoides a altas dosis**.

- **Dosis Inicial: Prednisona a 1-2 mg/Kg/día.** Se debe iniciar una **lenta reducción** en la dosis después de 4 a 6 semanas, buscando la dosis mínima eficaz.
- **DMARDs (Ahorrradores de Corticoides):** Se utilizan en combinación o como alternativa.
 - **Metotrexato** (si no hay contraindicación).
 - **Azatioprina.**
 - **Hidroxicloroquina.**
- **Compromiso Grave:** Para el **compromiso vasculítico** o **pulmonar** (neumopatía intersticial), se utilizan **pulsos de corticoides** más **Ciclofosfamida** o **Rituximab**.

2. Rehabilitación

La **rehabilitación precoz** es una parte fundamental del tratamiento. Los parámetros que permiten seguir la actividad de la enfermedad son la evolución de la **fuerza muscular** y los niveles séricos de **enzimas musculares (CK)**.

VASCULITIS SISTÉMICAS: CLASIFICACIÓN Y ALERTAS DIAGNÓSTICAS

Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por **infiltrados inflamatorios y necrosis sobre la pared de los vasos sanguíneos**. Esta pérdida de integridad puede causar sangrado, y el compromiso de la luz puede provocar **isquemia y necrosis del tejido irrigado**.

I. Clasificación por Calibre de Vaso (CHCC 2012)

La clasificación se basa en el tamaño predominante del vaso involucrado.

Calibre del Vaso	Vasculitis Más Relevantes
Grandes Vasos (Aorta y Ramas)	Arteritis de Células Gigantes (ACG) (o Temporal), Arteritis de Takayasu .
Vasos Medianos (Arterias Viscerales)	Poliarteritis Nodosa (PAN) , Enfermedad de Kawasaki.
Vasos Pequeños (Arteriolas, Capilares, Vénulas)	Vasculitis Asociadas a ANCA (VAA) : Granulomatosis con Poliangeítis (GPA), Poliangeítis Microscópica (PAM), Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeítis (GEPA).

II. Sospecha Diagnóstica: ¿Cuándo Pensar en Vasculitis?

Las vasculitis son a menudo enfermedades graves y, en ocasiones, **mortales** que requieren reconocimiento y tratamiento inmediatos.

1. Síntomas Constitucionales (Generales) 🤒

Se debe sospechar vasculitis en pacientes con síntomas sistémicos o constitucionales en combinación con evidencia de disfunción de uno o varios órganos.

- **Generales:** Fiebre, fatiga, **pérdida de peso** y artralgias.

2. Síntomas Sugestivos (Específicos) ⚠️

La combinación de síntomas en diferentes órganos sugiere un proceso vasculítico subyacente:

- **Lesiones Cutáneas: Púrpura palpable** (un signo fuerte de vasculitis leucocitoclástica cutánea). Estas lesiones típicamente **no desaparecen a la vitropresión**.
- **Compromiso Neurológico:** Neuropatía motora, como la **caída aguda del pie o de la muñeca**. La **mononeuritis múltiple** es la manifestación neuropática más típica en muchas formas de vasculitis.
- **Compromiso Vascular:** Claudicación de las extremidades, soplos o discrepancias en la presión arterial.
- **Síndrome Pulmón/Riñón:** Combinación de hemorragia pulmonar (hemoptisis inexplicable) e insuficiencia renal. La **Poliangeítis Microscópica (PAM)** es la causa más frecuente de este síndrome.

III. Vasculitis de Vasos Grandes: ACG y Takayasu

A. Arteritis de Células Gigantes (ACG) / Arteritis Temporal

- **Vasos Afectados:** Afecta predominantemente la **aorta y/o sus ramas principales**, con predilección por las **ramas de la carótida**, incluida la arteria temporal superficial.
- **Clínica Típica:** Ocurre **siempre en mayores de 50 años** (edad media 68 años).
 - **Cefalea** de reciente inicio bitemporal.
 - **Hipersensibilidad** en el cuero cabelludo.
 - **Arteria temporal palpable** y dolorosa.
 - **Claudicación mandibular**.
 - **Riesgo de Muerte/Secuela:** **Alteraciones visuales** como **amaurosis fugax**.
- **Lesión que Genera:** Es una vasculitis **granulomatosa**. El daño es por inflamación, que causa estenosis u oclusión.
- **Sospecha Diagnóstica:** Ante la clínica típica y **elevación de la VSG** (frecuentemente cercana a 100 mm en la primera hora) y la PCR.
- **Asociación Clave:** En el **30%** de los casos se asocia a la presencia de **Polimialgia Reumática (PMR)**.
- **Diagnóstico Definitivo:** **Biopsia de la arteria temporal superficial**.

B. Arteritis de Takayasu (AT)

- **Vasos Afectados:** Vasculitis granulomatosa que afecta la **aorta** y sus **ramas principales**. El sitio más común de afectación son las **subclavias**.
- **Clínica:** Predomina en **mujeres jóvenes** (20-30 años). Amplia variedad de síntomas, incluyendo **claudicación de las extremidades** (brazos o piernas). El principal factor pronóstico es la **Hipertensión Arterial (HTA)**.
- **Primer Hallazgo Típico del Examen Físico:** **Pérdida/disminución de pulsos** (ausentes o sensibles) y/o **discrepancias en la presión arterial**.

- **Diagnóstico:** Se basa en características clínicas y **hallazgos de imagen** de estenosis, oclusiones o dilataciones en la aorta y sus ramas. La **Angio-RM** es la exploración de elección.

IV. Vasculitis de Vasos Medianos y Pequeños (ANCA)

A. Poliarteritis Nodosa (PAN) (Vasos Medianos)

- **Vasos Afectados:** Arterias musculares de **mediano calibre** de forma segmentaria.
- **Serología ANCA:** ANCA **negativos**. Puede haber ANCA-P positivo en 10-15%.
- **Lesiones Principales:** Vasculitis **necrosante**.
 - **Neurológico:** **Mononeuritis múltiple** (la forma más característica).
 - **Cutáneo:** **Livedo reticularis**, nódulos, úlceras necróticas.
 - **Renal:** Compromiso por **isquemia**, sin glomerulonefritis (se acepta que la PAN clásica respeta las arteriolas, capilares y vénulas).
 - **Típico:** **Dolor testicular** (>10%) y **anormalidades angiográficas** (aneurismas u oclusiones de las arterias viscerales).
- **Riesgo de Muerte:** Los fallecimientos se deben a afección renal, digestiva, cardíaca y del SNC.

B. Granulomatosis con Poliangitis (GPA, ex Wegener) (Vasos Pequeños y Medianos)

- **Vasos Afectados:** Vasculitis **necrosante y granulomatosa** de vasos de **mediano y pequeño calibre**.
- **Serología ANCA:** ANCA-C PR3 **positivos** en 80-90%.
- **Lesiones Principales (Tríada):**
 1. **Vías Aéreas Superiores e Inferiores:** Afectación nasal, sinusal o del **oído** en el 90%. Manifestaciones comunes son **costras nasales**, **secreción nasal purulenta/sanguinolenta** y **obstrucción nasal**. La **estenosis subglótica** es la manifestación más común de la GPA traqueobronquial. Puede haber **hipoacusia**.
 2. **Pulmón:** **Nódulos parenquimatosos pulmonares** (**pueden cavitarse**).
 3. **Riñón:** **Glomerulonefritis rápidamente progresiva** (GN necrosante pauciinmune).

C. Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeítis (GEPA, ex Churg-Strauss) (Vasos Pequeños)

- **Clínica Típica:** Trastorno multisistémico caracterizado por **rinosinusitis crónica**, **asma** y **eosinofilia prominente**. El **asma** puede preceder años a la fase vasculítica.

- **Patrón Diferencial (Pulmón/Riñón):** "Siempre pulmón, poco riñón". A nivel pulmonar, presenta **infiltrados pulmonares inflamatorios migratrices** y nódulos. La **hemorragia pulmonar es rara**.
- **ANCA: ANCA-P MPO positivos** en 40-50%.
- **Riesgo de Muerte:** El **compromiso cardíaco** (arteritis coronaria o miocarditis) es responsable de más del **50% de las muertes** por esta enfermedad.
- **Diagnóstico Definitivo:** Se sospecha por la clínica de asma, eosinofilia e infiltrados pulmonares. La confirmación histológica mediante **biopsia** es crucial, mostrando vasculitis necrosante con **infiltración eosinófila** y **granulomas extravasculares**.

V. Fichas de Diagnóstico Diferencial (ANCA y Órganos)

Patrones ANCA y Vasculitis Específicas

Vasculitis	Vaso Afectado	Patrón ANCA/Antígeno	Manifestación Distintiva
GPA	Pequeño y Mediano	ANCA-C PR3 (80-90%)	Afectación Vías Aéreas Superiores (nariz, oído) y Glomerulonefritis .
PAM	Pequeño (arteriolas, capilares)	ANCA-P MPO (casi 90%)	Síndrome Pulmón-Riñón (GNRP severa, hemorragia alveolar).
GEPA	Pequeño	ANCA-P MPO (40-50%)	Asma, Eosinofilia y Corazón .
PAN	Mediano	ANCA Negativo	Aneurismas Viscerales, Dolor Testicular, Mononeuritis Múltiple, no GNF .

Características Radiológicas y Lesiones Típicas

- **PAN: Microaneurismas** y oclusiones de las arterias viscerales en la angiografía.
- **AT: Estenosis, oclusiones y dilataciones** en la aorta y sus ramas principales, visibles en Angio-RM/PET-TC.
- **ACG:** Engrosamiento de la pared arterial (hallazgo ecográfico o por RM).
- **GPA (Pulmón): Nódulos parenquimatosos** que pueden **cavitarse**.
- **Vasculitis Crioglobulinémica:** Se asocia a **niveles bajos de complemento sérico (C4)**.

Tratamiento de las Vasculitis Graves (Riesgo de Muerte)

El tratamiento en las formas graves (que comprometen órganos vitales como riñón, corazón o pulmón, o si hay hemorragia alveolar) consiste en una fase de inducción agresiva:

- **Glucocorticoides a altas dosis** (o pulsos de metilprednisolona).
- **Ciclofosfamida** o **Rituximab** como agentes inmunosupresores.
- La **Plasmaféresis** es útil en casos de GN proliferativa extracapilar con creatinina alta (> 5.6 mg/dL) o con **hemorragia alveolar**.

SÍNDROME DE SJÖGREN (SS): LA ENFERMEDAD DE LA SEQUEDAD

I. Concepto y Clínica Típica

El **Síndrome de Sjögren (SS)** es una **enfermedad autoinmune sistémica** que afecta especialmente al **sistema glandular exocrino**. Predomina significativamente en **mujeres** (10-15:1) y se diagnostica usualmente entre la **cuarta y sexta década de la vida**.

Puede presentarse como **SS primario** (aislado) o **SS secundario**, asociado a otras enfermedades autoinmunes, especialmente **Artritis Reumatoide (AR)** y **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**. La AR es la causa más frecuente de Sjögren secundario.

Síntomas de Sequedad (Síndrome SICCA)

Los síntomas de sequedad (SICCA) se deben a la disfunción glandular y están presentes en **más del 95%** de los pacientes.

- **Xerostomía (Boca Seca):** Dificultad para deglutir alimentos secos, necesidad de beber líquidos con frecuencia, lengua depapilada, caries y queilitis (boqueras).
- **Xeroftalmia (Ojos Secos):** Sensación de cuerpo extraño, ardor, fotosensibilidad, y secreción mucosa, causada por la **Queratoconjuntivitis Sicca**.
- **Otras Mucosas:** Tos seca, xerodermia (piel seca) y dispareunia.
- **Tumefacción Glandular:** Se puede presentar **hipertrofia parotídea** en un 10%-30% de los pacientes, frecuentemente **episódica**.

Manifestaciones Extraglandulares (Sistémicas)

- **Generales:** **Astenia**, fiebre y fatiga crónica, así como **adenopatías**.
- **Musculoesqueléticas:** **Mialgias** y **artralgias**. En ocasiones, **oligoartritis** o **poliartritis** que afectan sobre todo a las pequeñas articulaciones de ambas manos.
- **Vasculares/Cutáneas:** **Fenómeno de Raynaud** (10% de los pacientes). También **púrpura palpable** (asociada con frecuencia a crioglobulinemia) y lesiones cutáneas anulares.
- **Renales:** La afección renal más frecuente es la **Acidosis Tubular Renal Distal**. También se ha descrito **Glomerulonefritis**.

- **Neurológicas:** La más prevalente es la **Neuropatía Periférica** (polineuropatía axonal o multineuritis). También puede observarse neuralgia del trigémino.

II. Anticuerpos Característicos

En el Sjögren, la serología es fundamental para el diagnóstico y la evaluación de riesgo.

Autoanticuerpo	Prevalencia Típica	Valor Clínico y Asociación
Anticuerpos Antinucleares (ANA)	70%–90%	Son los más frecuentes. El paciente con SS cursa con ANA positivo .
Factor Reumatoideo (FR)	40%–60%	Elevado en cerca de la mitad de los casos.
Anti-Ro/SS-A	30%–70%	Es uno de los más específicos . Su positividad se asocia a afección extraglandular .
Anti-La/SS-B	10%–30%	Es uno de los más específicos .
ANA Anti-Ro/SS-A y Anti-La/SS-B	Variable	Asociados al desarrollo de Bloqueo Cardíaco Congénito intraútero en hijos de madres portadoras.

Laboratorio General: Otros datos incluyen **elevación de la VSG**, anemia normocítica, leucopenia e **hipergammaglobulinemia**.

III. Diagnóstico (Dx)

El diagnóstico del SS es complejo y requiere la objetivación de la sequedad glandular y el perfil inmunológico.

Componentes Diagnósticos

Para establecer el diagnóstico debe objetivarse disminución de la salivación, positividad para autoanticuerpos específicos (Ro/SS-A y/o La/SS-B) y realizarse una **biopsia de glándula salival menor**.

1. Evaluación Ocular (Xeroftalmia):

- **Prueba de Schirmer:** Mide la capacidad de humidificación lagrimal. Se considera anormal si la humidificación es **inferior a 5 mm** en 5 minutos en ambos ojos.
- **Tinción Corneal:** Estudia la lesión corneal.

2. Evaluación Salival (Xerostomía):

- **Flujos Salivales:** Determinación de la capacidad de secreción de saliva.
- 3. **Biopsia de Glándula Salival Menor:**
 - Es **necesaria** para el **diagnóstico**. Demuestra la **infiltración linfocitaria** de las glándulas exocrinas.

Complicación Grave (¡Riesgo de Cáncer!)

La complicación más grave del SS es la aparición de un **linfoma B** (especialmente en las glándulas parótidas), con un riesgo de **10 a 44 veces superior** al de la población general.

IV. Tratamiento (Tto)

No existe una terapéutica que modifique la evolución de la enfermedad. El tratamiento es, por lo tanto, sintomático y se centra en el manejo de la sequedad y, si es necesario, la inmunosupresión de la afectación sistémica.

1. Tratamiento Sintomático (Sequedad)

- **Sustitutos:** Uso de **saliva y lágrimas artificiales**.
- **Agentes Colinomiméticos:** **Pilocarpina** (5 mg/8 h por vía oral) puede mejorar la sequedad, especialmente la oral.
- **Afección Ocular Grave:** Uso de **ciclosporina A tópica** en colirio.

2. Tratamiento de Síntomas Generales/Articulares

- **Dolor/Artralgias:** Paracetamol, AINEs e **Hidroxicloroquina (HCQ)**.

3. Tratamiento para Afección Sistémica Grave

- **Glucocorticoides e Inmunosupresores:** Solo están indicados en pacientes con **afección sistémica grave**, incluyendo afectación del sistema nervioso, alveolitis pulmonar, glomerulonefritis y vasculitis sistémica. Se utilizan fármacos como la Azatioprina, Ciclofosfamida o Metotrexato.
- **Terapia Biológica:** Se han obtenido buenos resultados con **Rituximab** (terapias depletivas de células B) en pacientes con **afección sistémica grave** (sobre todo relacionados con **vasculitis crioglobulinémica**) o **linfoma**.